



RENCANA STRATEGIS

DEPUTI BIDANG KOORDINASI PENINGKATAN
KUALITAS KESEHATAN DAN PEMBANGUNAN
KEPENDUDUKAN TAHUN 2020 - 204



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh



Puji dan syukur kami panjatkan kepada Alloh SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya Deputy Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan telah menyelesaikan reviu penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Deputy Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan Tahun 2020-2024.

Renstra Deputy Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan 2020-2024 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 2020-2024 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah RPJMN 2020-2024.

Renstra Deputy Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan yang memuat mandat/tugas dan fungsi, kewenangan, peran menjalankan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian kondisi/isu-isu strategis, arah kebijakan dan strategi, program peningkatan kualitas kesehatan dan pembangunan kependudukan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan.

Renstra Deputy Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan diharapkan juga dapat menjadi salah satu panduan dalam penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi program maupun anggaran, serta pengembangan kebijakan dan kegiatan prioritas nasional.

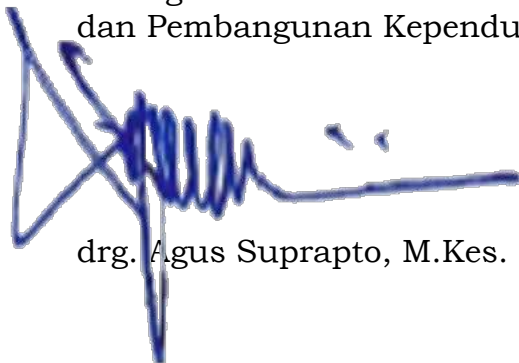
Seluruh Unit Kerja, Pimpinan dan Staf Deputy Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan harus dapat mengimplementasikan Renstra Deputy Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan 2020-2024 dengan berorientasi pada peningkatan kualitas KSP dan kinerja yang lebih baik untuk menjamin keberhasilan pencapaian target Indikator Kinerja Utama (IKU) Deputy Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan pada tahun 2024 dan pencapaian Visi Deputy Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan 2020-2024.

Akhir kata, kepada seluruh pihak yang turut membantu dalam proses reviu Renstra Deputy Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan 2020-2024, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Teima kasih.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Jakarta, Juli 2022
Deputy Bidang Koordinasi
Peningkatan Kualitas Kesehatan
dan Pembangunan Kependudukan

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'drg. Agus Suprpto, M.Kes.', is written over the printed name.

drg. Agus Suprpto, M.Kes.





KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG KOORDINASI PENINGKATAN KUALITAS
KESEHATAN DAN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN
NOMOR 9 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA STRATEGIS DEPUTI BIDANG KOORDINASI PENINGKATAN
KUALITAS KESEHATAN DAN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN
TAHUN 2020 - 2024

DEPUTI BIDANG KOORDINASI PENINGKATAN KUALITAS KESEHATAN
DAN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Tahun 2020 – 2024, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Rencana Strategis Deputy Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan Tahun 2020 – 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Deputy Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan tentang Perubahan atas Keputusan Deputy Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Deputy Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan Tahun 2020 – 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4464);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
6. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020 -2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 635);
8. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Tahun 2020 – 2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Tahun 2020 – 2024;

9. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
10. Keputusan Deputy Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Deputy Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan Dan Pembangunan Kependudukan Tahun 2020 – 2024;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG KOORDINASI PENINGKATAN KUALITAS KESEHATAN DAN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG KOORDINASI PENINGKATAN KUALITAS KESEHATAN DAN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA STRATEGIS DEPUTI BIDANG KOORDINASI PENINGKATAN KUALITAS KESEHATAN DAN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN TAHUN 2020 – 2024

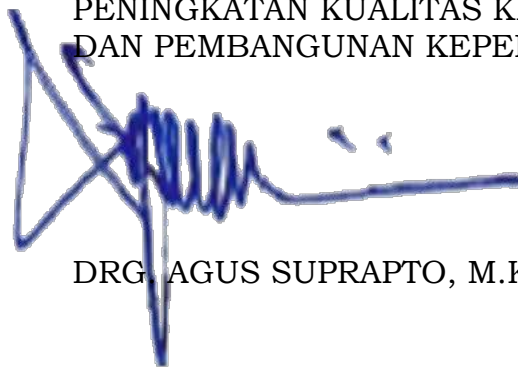
KESATU : Ketentuan Lampiran dalam Keputusan Deputy Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Deputy Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan Dan Pembangunan Kependudukan Tahun 2020 – 2024 diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan

Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan ini.

KEDUA : Peraturan Deputi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 September 2022

DEPUTI BIDANG KOORDINASI
PENINGKATAN KUALITAS KESEHATAN
DAN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN,

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized initial 'A' followed by a series of loops and a horizontal line extending to the right.

DRG. AGUS SUPRAPTO, M.KES.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG
KOORDINASI PENINGKATAN KUALITAS
KESEHATAN DAN PEMBANGUNAN
KEPENDUDUKAN KEMENTERIAN
KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN
MANUSIA DAN KEBUDAYAAN NOMOR 9
TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG
KOORDINASI PENINGKATAN KUALITAS
KESEHATAN DAN PEMBANGUNAN
KEPENDUDUKAN KEMENTERIAN
KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN
MANUSIA DAN KEBUDAYAAN NOMOR 2
TAHUN 2020 TENTANG RENCANA
STRATEGIS DEPUTI BIDANG KOORDINASI
PENINGKATAN KUALITAS KESEHATAN
DAN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN
TAHUN 2020 – 2024.

RENCANA STRATEGIS DEPUTI BIDANG KOORDINASI PENINGKATAN
KUALITAS KESEHATAN DAN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN
TAHUN 2020 – 2024.



DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Surat Keputusan Deputi Nomor 9 Tahun 2022.....	v
Bab 1. Pendahuluan.....	1
1.1 Kondisi Umum	2
1.2 Potensi dan Permasalahan.....	16
Bab 2. Visi, Misi dan Tujuan.....	20
2.1 Visi.....	21
2.2 Misi	22
2.3 Tujuan.....	23
2.4 Sasaran Strategis	25
2.5 Keterkaitan antara visi, misi, tujuan dan Sasaran Strategis.....	31
2.6 Nilai-Nilai Organisasi Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangu- nan Kependudukan.....	33
Bab 3. Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan.....	35
3.1 Agenda Pembangunan Nasional BidangPMK.....	35
3.3 Kerangka Regulasi.....	67
3.4 Kerangka Kelembagaan	68
Bab 4. Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan.....	73
4.1. Target Kinerja.....	71
4.2. Kerangka Pendanaan.....	75
Bab 5. Penutup.....	77
5.1 Kesimpulan.....	77
5.2 Arah dan Pimpinan dan Pelaksanaan Renstra.....	78
5.3 Mekanisme Evaluasi atas Renstra.....	80
Lampiran - Lampiran.....	82

BAB 1

PENDAHULUAN

Pada periode tahun 2015 – 2019 Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan fokus pada pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian (KSP) di bidang Peningkatan Kesehatan. Kemudian dalam rangka menyikapi dinamika sasaran atau target – target pembangunan, dan sebagai upaya penajaman nomenklatur untuk pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian (KSP) yang lebih efektif sesuai dengan RPJMN 2020 – 2024, maka 5 tahun kedepan akan fokus pada KSP pembangunan di bidang Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan.

Dalam dokumen RPJMN 2020-2024 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020, Kemenko PMK memiliki tanggung jawab terhadap upaya peningkatan kualitas pelayanan dasar dan pemenuhan kebutuhan dasar, kapabilitas pemberdayaan, dan nilai karakter manusia Indonesia dalam mendukung kemantapan gotong royong. Hal tersebut diterjemahkan ke dalam beberapa agenda pembangunan, yaitu Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan, Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing, Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan, dan Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan dan antisipasi bencana, dan perubahan iklim, yang masing-masing telah dipadukan dan sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) 2030.

Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing, dari dimensi kesehatan pada RPJMN 2020-2024 berfokus untuk Meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta terutama penguatan pelayanan kesehatan dasar (Primary Health Care) dengan mendorong peningkatan upaya promotif dan preventif, didukung inovasi dan pemanfaatan teknologi, melalui: 1) Peningkatan kesehatan ibu, anak, keluarga berencana (KB) dan kesehatan reproduksi; 2) Percepatan perbaikan gizi masyarakat; 3) Peningkatan pengendalian penyakit; 4)

Pembudayaan perilaku hidup sehat melalui Gerakan Masyarakat Hidup Sehat; 5) Penguatan sistem kesehatan dan pengawasan obat dan makanan. Adapun yang menjadi sasaran yang ditargetkan akan dicapai pada 2024, antara lain: 1) Angka Kematian Ibu sebesar 183 per 100.000 kelahiran hidup 2) Angka Kematian Bayi sebesar 16 per 1000 kelahiran hidup, 3) Prevalensi Stunting sebesar 14 persen, 4) Persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan sebesar 95 persen, 5) Persentase Imunisasi Dasar Lengkap Pada Anak Usia 12-23 bulan sebesar 90 persen*, dan 6) Desa/kelurahan Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS) sebesar 90 persen.

Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Balita (AKB) dan stunting masih tinggi dibandingkan target SDGs; faktor risiko penyakit tidak menular meningkat, kejadian penyakit menular masih tinggi, target air bersih dan sanitasi layak masih belum tercapai serta kualitas pelayanan kesehatan belum merata. Secara substansial, hal – hal mendasar ini yang kemudian menjadi dasar penyusunan Rencana Strategis Deputy Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan.

Penyusunan Renstra Strategis Deputy Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan ini berpedoman pada RPJMN Tahun 2020-2024, dan perubahan lingkungan strategis global dan nasional serta Renstra Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI. Segala perubahan lingkungan yang akan berpengaruh pada capaian target yang tercantum dalam RPJMN Tahun 2020-2024 akan berpengaruh pula pada capaian target dalam Deputy Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan Tahun 2020-2024. Sehingga dinamika yang terjadi akan menjadi bagian dari mekanisme review periodik untuk memastikan semuanya tetap mengarah pada tujuan awal.

1.1. Kondisi Umum

Berdasarkan Permenko Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan,

Deputi Bidang Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan merupakan nomenklatur baru dari nomenklatur sebelumnya, yaitu Deputi bidang Peningkatan Kesehatan.

Secara garis besar, pada bagian ini akan diuraikan capaian Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan periode 2015-2019 di mana fokus koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian (KSP) diarahkan pada kebijakan trimantap, yaitu: Mantap pelayanan (peningkatan kualitas hidup manusia Indonesia), Mantap pemberdayaan (peningkatan kapabilitas manusia Indonesia), dan Mantap pembangunan karakter yang berlandaskan gotong royong.

Kebijakan trimantap tersebut merupakan salah satu upaya KSP yang dilakukan Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan dalam mengintervensi kebijakan Kementerian/ Lembaga (K/L) dalam menangani isu-isu strategis bidang kesehatan yang bersifat multisektor yang tidak dapat diselesaikan K/L teknis secara sektoral.

Selain menganalisis dinamika isu-isu strategis yang berkembang luas di masyarakat, proses penjaringan aspirasi publik didapatkan juga melalui serangkaian survei kepuasan stakeholders atas pelayanan KSP Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan, Kemenko PMK dalam lima tahun terakhir.

1.1.1. Tugas dan fungsi Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan

Pada Perpres 35 tahun 2020, Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan, mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kesehatan dan pembangunan kependudukan. Kemudian dalam melaksanakan tugasnya, Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan menyelenggarakan fungsi:

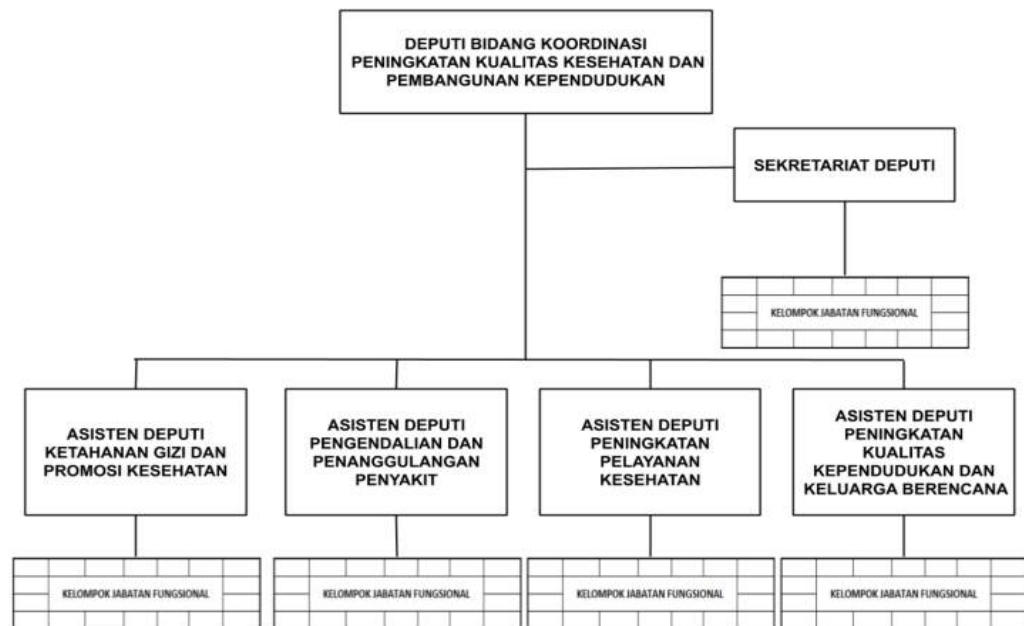
- a. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembagayang terkait dengan isu di bidang peningkatan kualitas kesehatan dan pembangunan kependudukan;
- b. pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembagayang terkait dengan isu di bidang peningkatan kualitas kesehatan dan pembangunan kependudukan;
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang peningkatan kualitas kesehatan dan pembangunan kependudukan; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator.

1.1.2. Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia

Struktur Organisasi di Deputy Bidang Koordinasi Peningkatan Kesehatan adalah dipimpin oleh seorang Deputy. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Deputy dibantu oleh 5 (lima) eselon II yaitu Sekretaris Deputy, Asisten Deputy (Asdep) Gizi dan Promosi kesehatan, Asdep Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit, Asdep Peningkatan Pelayanan Kesehatan, serta Asdep Peningkatan Kualitas Kependudukan dan Keluarga Berencana. Selain itu juga terdapat 8 orang Jabatan Fungsional Madya; 10 orang Jabatan Fungsional Muda; 17 orang staf dan 5 tenaga kontrak.

Dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2021, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, yang merupakan turunan dari Peraturan Presiden Nomor 35 tahun 2020 tentang Kemenko PMK, Struktur organisasi dan tata kerja Deputy Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan terlihat pada gambar 1.1.

Gambar 1.1. Struktur Organisasi Unit Kerja Deputy Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan



Sumber daya manusia (SDM) berperan penting dalam melaksanakan tugas dan fungsi Deputy Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan. Saat ini, jumlah pegawai di Deputy Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan, Kemenko PMK sebanyak 41 orang Aparatur Sipil Negara (ASN). Komposisi pegawai Kemenko PMK menurut jenis kelamin adalah pria 14 orang dan wanita 27 orang.

Menurut Tingkat Pendidikan terdiri dari S-2 sebanyak 20 orang, S-1 sebanyak 14 orang dan D-III sebanyak 3 orang, serta SLTA/Sederajat sebanyak 4 orang. Dengan tantangan yang semakin kompleks, Kemenko PMK harus melakukan peningkatan kompetensi SDM dan memprediksikan kebutuhan SDM untuk memperkuat tugas dan fungsi KSP dengan lingkungan strategis yang semakin dinamis.

Kombinasi antara SDM yang berkompeten, fungsional dan struktural akan menjadi salah satu penentu tercapainya target rencana strategis. Oleh karena itu, pengembangan SDM harus terus dilakukan untuk mengantisipasi berbagai dinamika dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Pejabat fungsional dari penyetaraan struktural harus didukung untuk dapat mengawal pelaksanaan tugas yang semakin baik.

1.1.3. Capaian Kinerja Deputy Bidang Koordinasi Peningkatan Kesehatan Tahun 2015 – 2019.

a. Capaian Indikator Pembangunan Nasional

Sesuai dengan kewenangan, tugas, dan fungsinya, selama tahun 2015 - 2019 Deputy Bidang Koordinasi Peningkatan Kesehatan menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan kualitas kesehatan dan pembangunan kependudukan di arahkan pada penanganan isu-isu strategis yang bersifat multisektor yang tidak mungkin diselesaikan K/L teknis secara sektoral untuk mendukung kebijakan Tri Mantap, yaitu:

1. Mantap pelayanan sebagai upaya memenuhi kebutuhan dan pelayanan dasar masyarakat dalam meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia;
2. Mantap pemberdayaan sebagai upaya dalam proses pemberdayaan masyarakat, khususnya peran keluarga, pemuda, dan perempuan dalam proses pembangunan untuk meningkatkan kapabilitas manusia Indonesia; dan
3. Mantap pembangunan karakter yang berlandaskan gotong royong sebagai upaya yang dilakukan bersama-sama dalam meningkatkan nilai-nilai luhur budaya bangsa.

Arah dan Fokus KSP yang dilakukan Deputy Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan Kemenko PMK melalui program Trimantap merupakan upaya dalam mempercepat capaian bidang PMK yang diukur secara makro sejak tahun 2015 sampai tahun 2019 melalui beberapa indikator, di antaranya capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Deputy Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan, sebagaimana pada Tabel 1.1. berikut ini :

Tabel 1.1 Capaian IKU Tahun 2015 – 2019
Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesehatan

No	Indikator Kinerja Utama	2015			2016			2017			2018			2019		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Indeks kepuasan Pemangku Kepentingan atas efektivitas dan efisiensi koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Peningkatan Kesehatan dalam mendukung kemandapan pelayanan dasar dan pemenuhan kebutuhan dasar					4,70 (skala 6)	4,91 (skala 6)	104,47	5,08 (skala 6)	5,01 (skala 6)	98,62	5,18 (skala 6)	5,22 (skala 6)	100,77		
2	Jumlah Rekomendasi Kebijakan (RK) Mendukung Kemandapan Pelayanan Dasar dan Pemenuhan Kebutuhan Dasar di Bidang Peningkatan Kesehatan					2	2	100	2	2	100	2	2	100		
3	Prosentase Rekomendasi Kebijakan (RK) Bidang Peningkatan Kesehatan yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan mendukung indikator kemandapan pelayanan dasar dan pemenuhan kebutuhan dasar											4	4	100		
4	Indeks kepuasan Pemangku Kepentingan atas efektivitas dan efisiensi koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Peningkatan Kesehatan dalam mendukung kemandapan pemberdayaan					4,70 (skala 6)	4,92 (skala 6)	104,68	5,11 (skala 6)	5,08 (skala 6)	99,41	5,20 (skala 6)	5,21 (skala 6)	100,19		
5	Jumlah RK Mendukung Kemandapan Pemberdayaan di Bidang Peningkatan Kesehatan					2	2	100	2	2	100	1	1	100		
6	Prosentase RK Bidang Peningkatan Kesehatan yang ditindaklanjuti menjadi Kebijakan mendukung indikator kemandapan pemberdayaan					2	2	100	2	2	100	2	2	100		
7	Indeks kepuasan Pemangku Kepentingan atas efektivitas dan efisiensi koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Peningkatan Kesehatan yang diarahkan pada pembangunan karakter bangsa dalam mendukung kemandapan gotong royong					4,70 (skala 6)	4,86 (skala 6)	103,40	5,05 (skala 6)	4,98 (skala 6)	98,61	5,18 (skala 6)	5,18 (skala 6)	100		
8	Jumlah RK yang diarahkan pada pembangunan karakter bangsa dalam mendukung kemandapan gotong royong Mendukung Kemandapan Gotong Royong di Bidang Peningkatan Kesehatan					2	2	100	2	2	100	2	2	100		
9	Prosentase Rekomendasi Kebijakan (RK) Bidang Peningkatan Kesehatan yang ditindaklanjuti menjadi Kebijakan yang diarahkan pada pembangunan karakter bangsa dalam mendukung indikator kemandapan gotong royong											2	2	100		
10	Nilai SAKIP	-	-	-	-	59,07	-	77,62	72,51	78,24	107,90	75,01	78,27	104,35		

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa Indeks kepuasan dari semua trimantab terus meningkat dari tahun 2015 – 2019. Selain itu target jumlah Rekomendasi Kebijakan dan Rekomendasi Kebijakan yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan, pada seluruh tri mantab tercapai.

Melengkapi table capaian tersebut, berikut ini adalah daftar kebijakan dimana Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesehatan, Kemenko PMK terlibat secara intensif dalam penyusunannya. Capaian kinerja pengelolaan dan penanganan isu di bidang peningkatan kesehatan dikelompokkan berdasarkan kebijakan tri mantap sebagai berikut:

Tabel 1.2. Hasil Penyusunan Perumusan Kebijakan, Penyelenggaraan Koordinasi dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan

Mantap Pelayanan	Mantap Pemberdayaan	Mantap Gotong Royong
• Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2019 tentang Kesehatan Kerja; • Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Tenaga Kesehatan; • Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pendayagunaan Dokter Spesialis;	• Inpres Nomor 1 tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat; • Instruksi Presiden Republik Indonesia	• Implementasi dari UU No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pengalihan status PKB/PLKB dari pegawai daerah

Mantap Pelayanan	Mantap Pemberdayaan	Mantap Gotong Royong
• Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2019 tentang Peningkatan Kemampuan Dalam Mencegah Mendeteksi, dan Merespons Wabah Penyakit, Pandemi Global, dan Kedaruratan Nuklir, Biologi, dan Kimia • Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Penelitian dan Pengembangan dalam Penyelenggaraan Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga • Pelaksanaan kebijakan program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) menjamin pelayanan kesehatan telah sesuai dengan ketentuan pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan	Nomor 3 Tahun 2017, tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat Dan Makanan • Perpres No.185 tahun 2014 tentang Percepatan penyediaan Air Minum dan Sanitasi Percepatan penyediaan Air Minum dan Sanitasi; • Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018, tentang Jaminan Kesehatan	menjadi pegawai pusat, sementara pemanfaatan tetap di daerah. • RINPRES Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung KB

Mantap pelayanan (Peningkatan Kualitas Hidup Manusia Indonesia).

KSP dalam rangka meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia difokuskan kepada pemenuhan kebutuhan dan pelayanan dasar masyarakat, khususnya di bidang kesehatan, dan kependudukan.

Peran Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan, Kemenko PMK dalam mengoordinasikan dan menyinkronisasikan K/L dalam perumusan dan penetapan kebijakan tahun 2015- 2019, di antaranya menghasilkan beberapa kebijakan bidang PMK yang mendukung peningkatan kualitas hidup manusia Indonesia, yaitu:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2019 tentang Kesehatan Kerja
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Tenaga Kesehatan;
- c. Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pendayagunaan Dokter Spesialis;

- d. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2019 tentang Peningkatan Kemampuan Dalam Mencegah Mendeteksi, dan Merespons Wabah Penyakit, Pandemi Global, dan Kedaruratan Nuklir, Biologi, dan Kimia;
- e. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Penelitian dan Pengembangan dalam Penyelenggaraan Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga.
- f. Di bidang kesehatan gizi, dilaksanakan KSP terkait Program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) yang merupakan gerakan yang bertujuan untuk memasyarakatkan budaya hidup sehat serta meninggalkan kebiasaan dan perilaku masyarakat yang kurang sehat. Peran Kemenko PMK adalah pengendalian pelaksanaan kebijakan Germas. Aksi Germas di antaranya aktivitas fisik, tidak merokok, tidak mengonsumsi minuman beralkohol, mengonsumsi buah dan sayuran, melakukan pemeriksaan secara berkala, menjaga kebersihan lingkungan, dan menggunakan jamban. Dengan Germas diharapkan dapat mengurangi angka stunting (tengkes) di Indonesia.
- g. Di bidang pelayanan kesehatan, untuk menjamin bahwa pelayanan kesehatan telah sesuai dengan ketentuan pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Dalam upaya memberikan akses dan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan menjamin pelayanan kesehatan yang diberikan telah sesuai dengan standar pelayanan minimal (SPM) kesehatan. Pengendalian Kemenko PMK dalam peningkatan pelayanan kesehatan adalah menjamin bahwa akses dan mutu pelayanan kesehatan semakin baik dan meningkat, baik dalam pemenuhan sarana, prasarana, dan SDM di fasilitas kesehatan, mulai dari fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) hingga fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut (FKRTL), optimalisasi sistem rujukan, maupun peningkatan mutu pelayanan kesehatan.

Mantap Pemberdayaan (Peningkatan kapabilitas Manusia Indonesia)

KSP dalam rangka meningkatkan kapabilitas manusia Indonesia difokuskan kepada upaya pemberdayaan masyarakat, khususnya peran

keluarga, pemuda, dan perempuan dalam proses pembangunan untuk meningkatkan kapabilitas manusia Indonesia.

Peran Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan, Kemenko PMK dalam mengoordinasikan dan menyinkronisasikan K/L dalam perumusan dan penetapan kebijakan tahun 2015- 2019, di antaranya menghasilkan beberapa kebijakan bidang PMK yang mendukung peningkatan kapabilitas manusia Indonesia, yaitu:

- a. Inpres Nomor 1 tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
- b. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017, tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat Dan Makanan
- c. Perpres No.185 tahun 2014 tentang Percepatan penyediaan Air Minum dan Sanitasi Percepatan penyediaan Air Minum dan Sanitasi
- d. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018, tentang Jaminan Kesehatan.

Mantap Pembangunan Karakter Berdasarkan Gotong-Royong

KSP dalam rangka pembangunan karakter difokuskan kepada upaya dalam meningkatkan nilai – nilai luhur budaya bangsa untuk membangun karakter manusia Indonesia.

Peran Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan, Kemenko PMK dalam mengoordinasikan dan menyinkronisasikan K/L dalam perumusan dan penetapan kebijakan tahun 2015- 2019, di antaranya menghasilkan beberapa kebijakan bidang PMK yang mendukung pembangunan karakter berdasarkan gotong royong, yaitu:

- a. Berdasarkan UU No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pengalihan status PKB/PLKB dari pegawai daerah menjadi pegawai pusat (BKKBN), sementara pemanfaatan tetap di daerah. Pada awalnya mengalami berbagai kendala antara lain anggaran, administrasi pengalihan, dan lainnya sehingga mengalami keterlambatan. Namun dengan KSP yang dilakukan Kemenko PMK dengan melibatkan K/L terkait serta pemerintah daerah provinsi, kabupaten/Kota, pengalihan dapat dilaksanakan di awal tahun 2018.

b. Hal lain yang telah dilakukan dalam proses pembangunan karakter berdasarkan gotong-royong adalah Program Kampung KB. Program Kampung KB merupakan program satuan wilayah (setingkat RW atau dusun) yang memadukan program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) dengan pembangunan sektor terkait (pemukiman, sosial ekonomi, kesehatan, pendidikan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak) secara sistemik dan sistematis.

Melalui Kampung KB diharapkan mampu menjadi episentrum program KKBPK di tingkat desa dalam rangka mengakselerasi capaian pembangunan di desa dan meningkatkan kesejahteraan rakyat di daerah 3T, perbatasan dan kepulauan, serta daerah perkotaan yang kumuh dan miskin. pembentukan kampung KB tentunya tidak lepas dari peran Kemenko PMK dalam mengoordinasikan dan mengolaborasi semua pemangku kepentingan sehingga mampu menumbuhkan-kembangkan komitmen yang kuat dari para pemangku kebijakan di semua tingkatan, integrasi lintas sektor, optimalisasi fasilitas dan dukungan mitra kerja, semangat dan dedikasi pengelola kampung KB, termasuk petugas lini lapangan, serta partisipasi masyarakat.

b. Capaian Kinerja Internal Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan.

Selain kinerja yang menggambarkan efektivitas sebuah organisasi dalam menjalankan mandat yang harus dilaksanakan sesuai tugas dan fungsi, perlu juga disampaikan keterukuran kinerja internal kelembagaan yang menjadi penopang terhadap kinerja fungsi utama dari suatu organisasi. Dalam meningkatkan kapasitas kelembagaan Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan Kemenko PMK yang akuntabel, maka Indikator kinerja yang dijadikan ukuran keberhasilan internal kelembagaan Kedeputian yaitu: (1) Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) dan (2) Nilai Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP).

Progres ketercapaian atas indikator dimaksud sebagaimana ditunjukkan Tabel 1.3 selalu meningkat setiap tahunnya. Hal ini

disebabkan adanya komitmen, kemauan, dan kesadaran dari pimpinan dan seluruh pegawai Deputy Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan untuk terus membenahi diri ke arah yang lebih baik, sehingga terus berkembang sesuai dengan tujuan yang diharapkan, yaitu pemerintahan yang berbasis kinerja.

Tabel 1.3. Capaian Kinerja Internal Tahun 2015 - 2019
Deputy Bidang Koordinasi Peningkatan Kesehatan

No	Indikator	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Nilai PMPRB	n.a	n.a	n.a	n.a	20,92
2.	Nilai SAKIP	-	59,07	77,62	78,24	78,26

Untuk memperkuat kapasitas kelembagaan, hal-hal yang menjadi perhatian/pertimbangan selama lima tahun ke depan, yaitu:

a. Reformasi Birokrasi

- Menyusun Roadmap Reformasi Birokrasi Deputy Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan Kemenko PMK 2020-2024;
- Menyusun Peta Proses Bisnis pelaksanaan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian secara eksternal dan internal sampai pada unit kerja;
- Melakukan reviu kelembagaan serta tata laksana secara berkala;
- Mendorong dan mengoptimalkan pelayanan dengan memanfaatkan teknologi informasi;
- Mendorong penerapan Merit System sebagai upaya akuntabilitas pengembangan pegawai;
- Mendorong penerapan delapan area perubahan dalam reformasi birokrasi sampai dengan tingkat satuan kerja eselon II.

b. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

- Meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, pengukuran, pelaporan sampai dengan monitoring dan evaluasi kinerja secara

berjenjang mulai dari tingkat Menteri sampai dengan tingkat pelaksana;

- Meningkatkan komitmen serta konsistensi berkelanjutan dari tingkat pimpinan sampai dengan tingkat pelaksana dalam penerapan sistem akuntabilitas kinerja melalui penerapan budaya kerja dan pemanfaatan informasi kinerja dalam pemberian reward and punishment;
- Meningkatkan pemanfaatan sistem informasi dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala serta pengembangan integrasi sistem perencanaan, penganggaran dan manajemen kinerja untuk dapat mempercepat penerapan performance based budgeting.

c. Administrasi Pengelolaan Keuangan

- Memperkuat pengendalian internal Deputy Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan mulai dari proses Perencanaan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban anggaran
- Konsistensi serta upaya perbaikan berkelanjutan dalam penerapan Administrasi Pengelolaan Keuangan
- Memperkuat pengendalian internal Deputy Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan Kemenko PMK mulai dari proses Perencanaan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban anggaran.
- Konsistensi serta upaya perbaikan berkelanjutan dalam penerapan.

Tabel 1.5. Capaian Kinerja Internal Tahun 2020 – 2022
Deputy Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan
Pembangunan Kependudukan

No.	Indikator	Tahun		
		2020	2021	2022
1.	Nilai PMPRB	33,00	35,09	35,24
2.	Nilai SAKIP	78,38	81,06	-

Tabel 1.6. Hasil Evaluasi Penilaian SAKIP
Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan
Pembangunan Kependudukan

NO.	UNSUR PENILAIAN	BOBOT %	Nilai 2020	Nilai 2021
1	PERENCANAAN KINERJA	30,00	21,58	26,23
2	PENGUKURAN KINERJA	25,00	21,25	20,83
3	PELAPORAN KINERJA	15,00	10,26	9,97
4	EVALUASI INTERNAL	10,00	7,75	7,75
5	PENCAPAIAN SASARAN/KINERJA ORGANISASI	20,00	17,54	16,28
TOTAL		100,00	78,38	81,06

Berdasarkan hasil evaluasi SAKIP Deputi Bidang PKKPK tahun 2020 - 2021 dengan lima aspek unsur penilaian, yakni perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal dan pencapaian sasaran/kinerja organisasi, tercapai nilai 81,06 atau mengalami kenaikan dibandingkan capaian penilaian SAKIP 2020, yaitu sebesar 78,38 atau adanya kenaikan sebesar 3,4 persen. Nilai ini masih dapat ditingkatkan kembali pada aspek akuntabilitas, yakni renstra Deputi Bidang PKKPK pada Indikator Implementasi Renstra (3 %) telah dilakukan review namun belum disahkan, dan pada indikator Kualitas Perencanaan Kinerja (10 %) masih terdapat ketidaksesuaian pada indikator kinerja.

Latar belakang dilakukannya revisi renstra Deputi Bidang Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan di tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Hasil rekomendasi atas evaluasi RB Kementerian PAN dan RB, khususnya pada area akuntabilitas.
2. Hasil evaluasi SAKIP 2021 dari Inspektorat Kemenko PMK, bahwa perlunya renstra dilakukan review setiap tahun berjalan untuk menyesuaikan kondisi dinamis dan startegis internal maupun eksternal yang mempengaruhi terhadap realisasi, capaian dan target

RPJMN 2020-2024, khususnya yang terkait dengan isu-isu strategis bidang peningkatan kualitas kesehatan dan pembangunan kependudukan.

3. Hasil evaluasi dari komite aparatur sipil negara terkait sistem merit dalam rencana pengembangan SDM di lingkungan Kemenko PMK.
4. Penyesuaian matriks kinerja dan kerangka pendanaan berdasarkan redesign sistem perencanaan dan penganggaran.

1.1.4 Aspirasi Pemangku Kepentingan Terhadap Peran, Tugas, dan Fungsi Organisasi.

Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan Kemenko PMK memiliki posisi strategis di bidang Kesehatan dan Kependudukan yang terkait dengan proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan yang dikoordinasikan oleh Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan Kemenko PMK. Selaku koordinator, tentunya perlu mengetahui tingkat kepuasan para pemangku kepentingan terhadap kualitas koordinasi yang dilakukan oleh Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan Kemenko PMK.

Dalam lima tahun terakhir, Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan Kemenko PMK melakukan survei untuk mengetahui tingkat kepuasan pemangku kepentingan atas efektivitas dan efisiensi koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan, serta pengendalian kebijakan, yang diarahkan kepada tiga mantap (mantap pelayanan, mantap pemberdayaan, dan mantap pembangunan karakter). Survei dilaksanakan pada saat pelaksanaan kegiatan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian (KSP) dan bekerjasama dengan pihak ketiga yang bertujuan untuk menjaga kualitas dan independensi hasil survei. Survei dilakukan kepada K/L terkait serta pihak-pihak lain, baik dengan instansi di bawah koordinasi Kemenko PMK maupun instansi lainnya yang pernah berkoordinasi dengan Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan Kemenko PMK.

Hasil dari survei yang telah dilaksanakan selama lima tahun terakhir menunjukkan adanya kecenderungan peningkatan angka Indeks kepuasan pemangku kepentingan atas kualitas KSP sebagai berikut:

Tabel 1.7. Hasil Survei Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan (Skala 6) Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesehatan

No	Trimantap	2015		2016		2017		2018		2019	
		Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
1	Mantap Pelayanan (IKS-L)	-	-	-	-	4,70	4,91	5,08	5,18	5,18	5,22
2	Mantap Pemberdayaan (IKS-B)	-	-	-	-	4,70	4,92	5,11	5,08	5,20	5,21
3	Mantap Pembangunan Karakter (IKS-K)	-	-	-	-	4,70	4,86	5,05	4,98	5,18	5,18

Secara umum skor dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, dan tahun 2019 masuk dalam kategori “sangat memuaskan” karena berada pada rentang angka 5,18-6,00. Namun demikian, kualitas pelayanan koordinasi tersebut masih perlu ditingkatkan, karena masih terdapat unsur-unsur layanan yang perlu diperbaiki, antara lain: (1) Pelaksanaan KSP secara tepat waktu, (2) Kompetensi SDM dalam pelaksanaan KSP, (3) Manfaat dari layanan KSP yang dapat dirasakan dalam setiap kebijakan, serta (4) Perumusan hasil KSP yang tepat sesuai dengan sasaran atau target yang didiskusikan.

Lima tahun ke depan yang perlu diperkuat dan dikembangkan dalam melaksanakan pembangunan nasional bidang PMK (2020-2024), yaitu: (1) Peningkatan kualitas SDM Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan, Kemenko PMK dalam menjalankan peran KSP dalam perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan; (2) Peningkatan kualitas dan kapasitas kelembagaan dalam mendukung peran KSP dalam perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan.

1.2 Potensi dan Permasalahan

Pada bagian ini akan dibahas analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats), yaitu potensi dan

permasalahan yang dihadapi Deputy Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan, Kemenko PMK pada jangka menengah, baik secara makro dalam lingkup nasional maupun dalam lingkup internal kelembagaan.

Seluruh pembahasan diuraikan dalam perspektif pembangunan kualitas manusia Indonesia, kemajuan yang mencerminkan kepribadian bangsa, serta pembangunan yang merata dan berkeadilan demi terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Perspektif tersebut dipahami dalam kerangka penugasan yang diamanatkan RPJMN sesuai lingkup kewenangan yang dimiliki dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi Kemenko PMK yang diturunkan dari dan selaras dengan Visi dan Misi Presiden.

Dalam rencana strategis ini, pemahaman tentang potensi mencakup dua hal pokok, yaitu aspek kesempatan (opportunities) yang terkait dengan dinamika lingkungan strategis eksternal Deputy Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan Kemenko PMK dan aspek kekuatan (strengths) yang berkaitan dengan dinamika kondisi internal kelembagaan Deputy Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan, Kemenko PMK.

Sedangkan pemahaman tentang permasalahan mencakup dua hal pokok lainnya, yaitu aspek ancaman (threats) yang berasal dari dinamika lingkungan eksternal dan aspek kelemahan (weaknesses) yang berkaitan dengan aspek internal organisasi Deputy Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan Kemenko PMK.

1.2.1 Perubahan Lingkungan Strategis

Untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi dan strategi yang perlu dilakukan, telah diidentifikasi kekuatan (Strengths), kelemahan (Weakness), peluang / kesempatan (Opportunities), dan ancaman / tantangan (Threats), sebagaimana tabel 1.8 di bawah ini:

Tabel 1.8. Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman
Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesehatan

Lingkungan Internal		Lingkungan Eksternal	
Kekuatan	Kelemahan	Peluang	Ancaman
- Komitmen Pimpinan yang kuat dalam upaya meningkatkan kualitas KSP. - SDM Aparatur yang Kompeten - Ketersediaan sarana kerja yang memadai, termasuk teknologi informasi modern. - Peraturan perundang undangan yang mendukung KSP - Sistem informasi manajemen.	- Jumlah SDM Aparatur kurang dan struktur tidak terisi - Kurangnya dukungan pelatihan teknis pelaksanaan tugas/pengembangan keterampilan - Sistim manajemen internal yang birokratis dan kaku - Dukungan IT belum siap untuk model kerja WFH - Belum adanya mekanisme kerja yang dinamis untuk mendukung perubahan pola kerja new normal.	- Mendukung peningkatan kualitas kesehatan - Mendukung peningkatan kualitas pembangunan kependudukan - Kondisi keamanan, sosial, dan ekonomi yang kondusif - Inovasi- inovasi dalam pelayanan kesehatan - Bonus Demografi. - Berkembangnya IT sebagai literasi teknologi	- Disparitas status kesehatan antar wilayah - Ketersediaan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan - Daya saing Belum optimalnya menghadapi MEA. untuk pemenuhan alat dan obat. - Maldistribution tenaga kesehatan. - Sarana dan prasarana kesehatan yang belum mencukupi - Inovasi- inovasi dalam pelayanan kesehatan masih tertinggal. - Dampak ekonomi, sosial, dan budaya pandemic covid-19 - Bencana demografis akibat kesalahan pengelolaan sumber daya produktif

Berdasarkan analisis lingkungan Internal dan lingkungan Eksternal (SWOT) di atas, Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan dapat menentukan strategi untuk menghadapi berbagai kondisi 5 tahun kedepan, yaitu dengan mengoptimalkan kekuatan dan peluang yang ada, untuk mengatasi kelemahan dan ancaman yang dihadapi.

Untuk itu berikut adalah faktor-faktor kunci keberhasilan yang dapat dioptimalkan untuk melalui 5 tahun kedepan dengan sukses mencapai target – target pembangunan yang telah ditentukan, antara lain sebagai berikut:

- Meningkatkan kuantitas, kapasitas dan kompetensi SDM antara lain melalui pengusulan pengangkatan dan pembinaan jabatan fungsional, mulai dari tingkat jabatan terendah sampai tertinggi secara berjenjang; capacity building; penambahan SDM.
- Perlunya disusun gap kompetensi untuk memastikan the right man at the right place; dan engan adanya kebijakan pemerintah tentang jabatan fungsional, maka perlu dikembangkan pola pelatihan serta diklat bagi setiap pegawai.

- c. Mengembangkan dan memanfaatkan sistem informasi secara optimal dalam pelaksanaan tugas dan fungsi agar efektif dan efisien.
- d. Mengoptimalkan pelaksanaan fungsi pengawasan, monitoring dan evaluasi serta melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) atas pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan sesuai tugas dan fungsi Deputy Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan.

Faktor-faktor kunci keberhasilan dapat dilaksanakan dengan langkah-langkah strategi yang akan diuraikan lebih lanjut dalam Bab III Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi, dan Kerangka Kelembagaan.

BAB II

VISI, MISI, DAN TUJUAN

Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan memiliki peran yang sangat strategis yaitu sebagai koordinator dua isu penting: Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian (KSP) yang dilaksanakan Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan mendukung pencapaian 1 (satu) dari 7 (tujuh) Agenda Pembangunan dalam RPJMN 2020-2024 yaitu: Agenda Pembangunan 3 (Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing).

Visi Misi Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan merupakan penjabaran dari Visi Misi Kemenko PMK dalam mendukung Visi Misi Presiden 2020-2024. Visi Presiden 2020-2024 adalah “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, Berlandaskan Gotong Royong.” Visi Presiden tersebut akan tercapai melalui sembilan misi Presiden, yaitu (1) Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia, (2) Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing, (3) Pembangunan yang merata dan berkeadilan, (4) Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan, (5) Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa, (6) Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya, (7) Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga, (8) Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya, dan (9) Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Lebih lanjut, sebagai strategi untuk menjalankan visi dan misi tersebut Presiden menyampaikan lima arahan, yaitu (1) Pembangunan SDM, (2) Pembangunan infrastruktur, (3) Penyederhanaan regulasi, (4) Penyederhanaan birokrasi, dan (5) Transformasi ekonomi.

Kemudian lima strategi tersebut dijabarkan dalam tujuh Agenda Pembangunan, yaitu (1) Memperkuat ketahanan ekonomi untuk

pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan (2) Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan, (3) Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing, (4) Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan, (5) Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar, (6) Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim, (7) Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan, dan keamanan, dan transformasi pelayanan publik. Misi, Arah Presiden, dan Agenda Pembangunan dalam RPJMN 2020-2024 seperti terlihat pada Gambar 2.1.

Gambar 2.1. Pedoman Pembangunan Nasional 2020 - 2024



2.1. Visi Deputy Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan.

Deputy Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan mengandung maksud bahwa fungsi dan mandat Deputy Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan berfokus pada dua tema besar, yaitu mengoordinasikan Peningkatan Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan yang memiliki arti penting dalam mencapai visi Presiden

“Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, Berlandaskan Gotong Royong”.

Dalam Rencana Strategis Kemenko PMK 2020-2024, telah ditetapkan Visi Kemenko PMK 2020-2024, yaitu: “Menjadi Lembaga Koordinator Pelaksanaan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang efektif dan berkelanjutan untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berdasarkan Gotong Royong.”

Sejalan dengan visi Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan diatas diatas, maka visi Deputy Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan adalah: “Menjadi unit kerja koordinator pelaksanaan Peningkatan kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan (PKKPK) yang efektif dan berkelanjutan untuk mewujudkan Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong royong”.

Dalam visi tersebut, Menjadi Koordinator berarti bahwa Deputy Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan selaku Koordinator berperan dalam melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan K/L terkait dengan isu di bidang Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan, dengan berbagai cara yang berorientasi pada keefektifan dan keberlanjutan.

2.2. Misi Deputy Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan

Dalam rangka mewujudkan Visi Deputy Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan dan Pembangunan Kependudukan` dibutuhkan tindakan nyata dalam penetapan Misi yang sesuai dengan peran Deputy Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan sebagai berikut: (1).Meningkatkan pembangunan manusia dan kebudayaan yang berkualitas dan berkelanjutan melalui peningkatan kualitas kesehatan dan pembangunan kependudukan; (2). Meningkatkan kapasitas kelembagaan”.

Misi mengandung arti bahwa Deputy menjalankan tiga peran, yaitu (1) Koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan penetapan kebijakan di bidang Kesehatan dan Kependudukan. Perumusan dan penetapan kebijakan merupakan upaya yang dilakukan dalam menyusun berbagai kebijakan yang bersifat strategis, lintas sektor, dan berdampak luas terhadap masyarakat yang dilakukan oleh K/L di bidang Kesehatan dan Kependudukan. (2) Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Kesehatan dan Kependudukan merupakan proses pengintegrasian dan penyelarasan (harmonisasi) berbagai program dan kegiatan bidang Kesehatan dan Kependudukan yang ada pada K/L untuk menghasilkan keputusan dan kesatuan tindakan dalam mencapai tujuan atas kebijakan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien, serta dan memberikan dampak yang besar bagi masyarakat. Akhirnya (3) Pengendalian pelaksanaan kebijakan merupakan upaya yang dilakukan melalui instrumen yang terstruktur untuk mengarahkan suatu kebijakan sesuai dengan yang ditetapkan, sehingga dapat mencapai sasaran pembangunan nasional bidang Kesehatan dan Kependudukan secara efektif dan efisien.

2.3. Tujuan Strategis Deputy Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan.

Tujuan Deputy Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan diartikan sebagai suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun, yang menjadi arah dan dimensi koordinator, serta arah dan dimensi pembangunan nasional bidang Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan. Di dalam tujuan terdapat indikator tujuan, yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian tujuan untuk diwujudkan pada periode lima tahun. Tujuan tersebut mengacu kepada pernyataan visi yang ingin diwujudkan dan misi yang akan dilaksanakan.

Tujuan Deputy Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan secara substantif ditetapkan agar mampu memberikan arah pada perumusan sasaran, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. Dalam kaitan tersebut penting untuk digarisbawahi arahan Presiden, khususnya butir pertama,

ketiga, dan keempat, yaitu Pembangunan SDM, Penyederhanaan Regulasi, dan Penyederhanaan Birokrasi.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, rumusan Tujuan Deputy Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan untuk mendukung upaya pencapaian dan perwujudan Visi dan Misi Deputy Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan, sebagaimana Tabel 2.1.

Tabel 2.1: Tujuan dan Indikator Tujuan 2020-2024

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET 2020	TARGET 2024
T.1 Terwujudnya Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan yang berkesinambungan	Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM)	0,6087	Meningkat
T.2. Tercapainya birokrasi yang handal, terpercaya, dan akuntabel	Nilai SAKIP	80,01	85,50

Tujuan pertama terkait dengan upaya peningkatan kualitas kesehatan dan pembangunan kependudukan yang berkesinambungan dilakukan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.

Keberhasilan terhadap pencapaian tujuan pertama diindikasikan dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM). IPKM adalah kumpulan indikator kesehatan yang dapat dengan mudah dan langsung diukur untuk menggambarkan masalah kesehatan. Serangkaian indikator kesehatan ini secara langsung maupun tidak langsung dapat berperan meningkatkan umur harapan hidup yang panjang dan sehat. Prinsip umum indikator yang digunakan dalam penyusunan IPKM adalah sederhana, mudah, dapat diukur, bermanfaat,

dipercaya, dan tepat waktu. Indikator-indikator terpilih dalam IPKM lebih menunjukkan dampak dari pembangunan kesehatan tahun sebelumnya dan menjadi acuan perencanaan program pembangunan kesehatan untuk tahun berikutnya, hal inilah yang mendasari penetapan tujuan dari Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan, disamping itu tujuan tersebut sejalan dengan tujuan Kemenko PMK.

Tujuan kedua, tercapainya birokrasi yang sederhana, namun handal, terpercaya, dan akuntabel sebagaimana ditetapkan pada tujuan kedua menjadi prasyarat dan syarat bagi kesanggupan dan kompetensi Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan dalam menjalankan peran, tugas, dan fungsinya. Birokrasi yang sederhana, handal, terpercaya, dan akuntabel mengindikasikan upaya lembaga untuk melakukan perubahan mendasar dari aspek-aspek mentalitas SDM Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan untuk menjadi pelayan yang amanah dalam proses pelayanan publik sekaligus menjadi SDM profesional yang tangkas dan gesit dalam menjalankan tugas profesi sebagai aparatur Negara. Mentalitas SDM aparatur yang semakin profesional dalam pelayanan dan ditunjang dengan organisasi, serta manajemen yang efektif akan meningkatkan mutu organisasi yang berdampak pada kemampuan menjalankan peran, tugas, dan fungsi yang telah diamanatkan.

2.4. Sasaran Strategis dan Indikator

Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai oleh Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan secara nyata dalam rumusan yang spesifik, terukur, dan dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Di dalam sasaran strategis terdapat indikator sasaran strategis, yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran strategis untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Sasaran strategis diupayakan dapat dicapai dalam kurun waktu 2020-2024 secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis.

Sasaran strategis merupakan penjabaran dari tujuan Deputy Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan yang menggambarkan sesuatu yang akan dicapai melalui serangkaian kebijakan, program, dan kegiatan prioritas melalui penggunaan sumber daya yang efisien dan efektif dalam upaya pencapaian visi dan misi Deputy Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan.

Sasaran strategis merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh Deputy Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan. Sasaran strategis ini mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil dari dua jenis program Deputy Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan, yaitu:

1. Program teknis, yang mencerminkan fungsi koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan isu di bidang Kesehatan dan Kependudukan.
2. Program generik, merupakan program yang bersifat pelayanan internal untuk mendukung pelaksanaan program teknis dan administrasi di lingkungan Deputy Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan.

Adapun tujuan dan sasaran strategis Deputy Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan dapat dilihat pada Tabel 2.2 Sasaran strategis ini akan digunakan sebagai dasar penyusunan Indikator Kinerja Sasaran Strategis dan menjadi dasar penyusunan arah kebijakan dan strategi Deputy Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Kependudukan.

Tabel 2.2: Tujuan dan Sasaran Strategis 2020-2024

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS
T.1. Terwujudnya Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan yang berkesinambungan	SS-1 Meningkatnya Implementasi Kebijakan Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan yang maju dan berkelanjutan
	SS-2 Meningkatnya Kualitas Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan dan Penetapan Kebijakan Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan
	SS-3 Meningkatnya Kualitas Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan
	SS-4 Meningkatnya Kualitas Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan
T.2. Tercapainya birokrasi yang handal, terpercaya, dan akuntabel	SS-5 Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Deputi Bidang Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan.

Sasaran strategis pertama merupakan kondisi yang ingin dicapai secara nyata terkait dengan tercapainya koordinasi, sinkronisasi kelembagaan yang mantap dan pengendalian yang efektif dalam perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan. Ketercapaian koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian yang semakin meningkat dapat diindikasikan pada konteks seberapa besar tingkat realisasi koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian dibandingkan dengan yang telah direncanakan.

Selain itu ketercapaian juga diindikasikan dari seberapa besar tingkat kepuasan stakeholders Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan dalam melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian pada pelaksanaan kebijakan kesehatan dan kependudukan yang dijalankan oleh

Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan.

Sementara itu, sasaran strategis kedua diharapkan berapa banyak jumlah isu-isu strategis bidang Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan bidang PMK dalam jangka waktu lima tahun. Setiap tahun minimal 20% isu-isu strategis ditindaklanjuti menjadi kebijakan disesuaikan dengan unit pelaksana (deputi) Kemenko PMK. Kemudian sasaran strategis ketiga dan keempat yaitu melakukan survei terhadap kementerian dan lembaga lingkup Kemenko PMK, dan dilakukan bersama Pihak Ketiga setiap akhir tahun. Hasil akhirnya adalah indeks kepuasan pemangku kepentingan atas koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan yang telah dilakukan.

Sasaran strategis ke-lima yaitu hasil penilaian Kemanpan RB. Hasilnya tercapainya birokrasi yang sederhana, namun handal, terpercaya, dan akuntabel yang mengindikasikan upaya lembaga untuk melakukan perubahan mendasar dari aspek-aspek mentalitas SDM untuk menjadi pelayan yang amanah dalam proses pelayanan publik sekaligus menjadi SDM profesional yang tangkas dan gesit dalam menjalankan tugas profesi sebagai aparatur Negara.

Tabel 2.3: Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator Kinerja, dan Target

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2020	Target 2024
T 1. Terwujudnya Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan yang berkesinambungan	SS-1 Meningkatnya Implementasi Kebijakan Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan yang maju dan berkelanjutan	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	24,1	14
		Persentase imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12-23 bulan	64	90
		Persentase rumah sakit terakreditasi	80	100

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2020	Target 2024
		Angka kelahiran Total (TFR)	2,26	2,1
	SS-2 Meningkatnya Kualitas Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan dan Penetapan Kebijakan Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan	Persentase isu-isu strategis Bidang Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan yang ditindaklanjuti menjadi Kebijakan Bidang Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan	20%	100%
	SS-3 Meningkatnya Kualitas Koordinasi Dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan	Indeks kepuasan pemangku kepentingan terhadap atas koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan	4,80 (SKALA 6)	5,37 (SKALA 6)
	SS-4 Meningkatnya Kualitas Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan	Indeks Pengendalian bidang Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan	Level 3	Level 5
T.2. Tercapainya birokrasi yang handal, terpercaya, dan akuntabel	SS-5 Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Deputy Bidang Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan.	Nilai Reformasi Birokrasi (Baseline Nilai SAKIP 2019: 75,72)	80,01	85,50

Sasaran Strategis Pertama (SS-1) dimaksudkan untuk memenuhi harapan dan aspirasi masyarakat luas, yaitu terimplementasinya Kebijakan Peningkatan Kualitas Kesehatan Dan Pembangunan Kependudukan (PKKPK). Sasaran strategis tersebut merupakan hasil yang dicapai karena terlaksananya SS-2, SS-3, dan SS-4, yaitu kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan penetapan kebijakan (SS-2), kualitas koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan (SS-3), serta kualitas pengendalian pelaksanaan Kebijakan Peningkatan Kualitas Kesehatan Dan Pembangunan Kependudukan (SS-4).

Adapun indikator kinerja SS-1 Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan, Cascading dengan indikator kinerja SS-1 Menteri Koordinasi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, yaitu Indeks Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Indeks PMK).

Indeks PMK berupa indeks komposit yang terdiri dari 31 variabel dengan 3 aspek (Peningkatan Kualitas, Kapabilitas dan Pembangunan Karakter Manusia Indonesia), yang proses pengukuran dilakukan oleh Tim terdiri dari KPMK, Badan Pusat Statistik, dan LSM.

Aspek peningkatan kualitas manusia Indonesia dari sisi layanan kesehatan, variable yang masuk dalam perhitungan Indeks PMK adalah: (1). Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita; (2). Persentase imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12-23 bulan; dan (3). Persentase Persentase rumah sakit terakreditasi; (4) Angka kelahiran Total (TFR).

SS-5 merupakan prasyarat logis dan wajib agar fungsi KSP yang dijalankan Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan Dan Pembangunan Kependudukan (PKKPK) dapat semakin berkualitas. Prasyarat logis dan wajib tersebut tercermin dalam proses bisnis yang sederhana, berkualitas, dan efektif di delapan area birokrasi yang membutuhkan reformasi, yaitu manajemen perubahan, penataan peraturan perundang-undangan, penataan dan pengauatan organisasi, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan

akuntabilitas, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

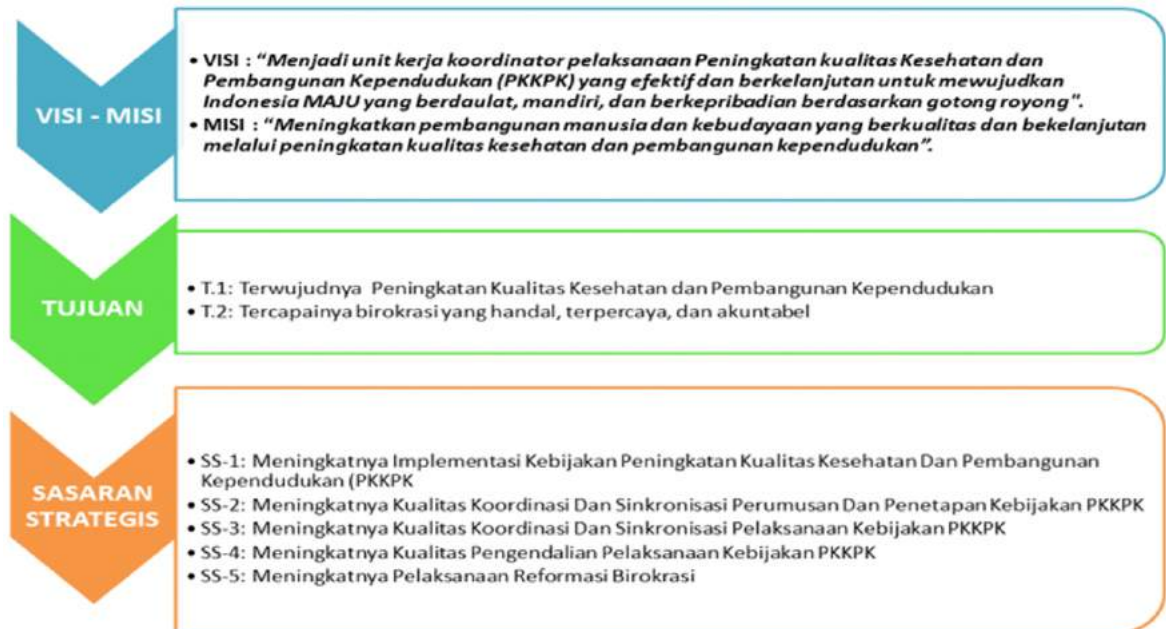
Secara khusus dalam SS-5, Strategi Deputy Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan Dan Pembangunan Kependudukan (PKKPK) memberi perhatian pada prasyarat agar proses bisnis dan reformasi birokrasi semakin efektif dan berkualitas. Prasyarat tersebut adalah proses pembelajaran dan pengembangan kualitas SDM yang unggul serta optimalisasi teknologi informasi dan big data.

2.5. Keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis

Ringkasan atas uraian di atas, pada Gambar 2.2 memperlihatkan keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis Deputy Bidang Koordinasi Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan (PKKPK).

Visi dan Misi Deputy Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan (PKKPK) menjadi arahan utama yang memberi petunjuk ideal semua aktivitas dalam lingkup Deputy Bidang Koordinasi Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan Dan Pembangunan Kependudukan (PKKPK). Visi Deputy Bidang Koordinasi Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan (PKKPK) hendak menjawab tentang jati diri Organisasi, yaitu sebagai Lembaga Koordinator Pelaksanaan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan di Indonesia yang dijalankan secara efektif dan berkesinambungan. Misi Deputy Bidang Koordinasi PKKPK hendak menjawab yang dikerjakan oleh Deputy Bidang Koordinasi PKKPK, yaitu meningkatkan kualitas kesehatan dan pembangunan kependudukan.

Gambar 2.2. Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis



Berdasarkan Gambar 2.2 Visi dan Misi Deputy Bidang Koordinasi PKKPK diletakkan dalam lapisan tertinggi. Yang selanjutnya diturunkan dalam dua tujuan yang memberi arah yang lebih terhadap semua aktivitas dalam kelembagaan agar Visi kelembagaan dapat tercapai dan Misi kelembagaan dapat dijalankan dengan baik. Tujuan mengindikasikan ukuran efektivitas program dan kegiatan-kegiatan yakni (1) terwujudnya peningkatan kualitas kesehatan dan pembangunan kependudukan, serta (2) tercapainya birokrasi yang handal terpercaya dan akuntabel.

Tujuan Strategis tersebut kemudian dijabarkan dalam lima Sasaran Strategis yang pada intinya menjabarkan Sasaran Strategis sesuai dengan fungsi Deputy Bidang Koordinasi PKKPK (SS-1 s.d. SS-4) serta Sasaran Strategis yang bersifat generik (SS-5).

Tujuan dan Sasaran Strategis tersebut selaras dengan peta strategi Kemenko PMK 2020-2024. Gambar 2.3 memperlihatkan peta strategi tersebut. Peta strategi terbagi dalam empat lapisan (layers) yang menunjukkan proses tercapainya Tujuan Strategis. Peta strategi dimulai dengan proses perbaikan terus menerus kualitas birokrasi (SS-5).

Lapisan pertama ini disebut layer of learning and growth. Pada layer berikutnya, yaitu layer of strategic driven sebagai bisnis proses yang menghasilkan output berupa koordinasi perumusan kebijakan (SS-2), output koordinasi pelaksanaan kebijakan (SS-3), dan output pengendalian kebijakan (SS-4). Layer of strategic outcome merupakan akibat dari bisnis proses, yaitu meningkatnya implementasi kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan (SS-1) yang pada gilirannya memberi impact, yaitu tercapainya tujuan strategis (layer of strategic impact).

Gambar 2.3. Peta Strategi Deputy Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan



2.6. Nilai-nilai Organisasi Deputy Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan Kemenko PMK

Dalam proses pencapaian visi, misi, dan tujuan organisasi, diperlukan budaya kerja yang kuat melalui fondasi nilai-nilai organisasi yang akan dijadikan pedoman oleh seluruh pegawai Deputy Bidang Koordinasi PKKPK Kemenko PMK. Nilai-nilai organisasi berperan dalam membangun kesadaran bersama untuk memiliki sifat, perilaku, peran, pelayanan, komunikasi, dan kontribusi kepada organisasi dan stakeholders dalam satu persepsi dan satu keyakinan. Oleh karena itu, untuk tahun 2020-2024, Deputy Bidang Koordinasi PKKPK, Kemenko

PMK telah menetapkan nilai-nilai organisasi yang sejalan dengan semangat revolusi mental dan semangat reformasi birokrasi, yaitu:

1. Integritas

Dalam integritas terkandung makna bahwa para pegawai Kemenko PMK berpikir, berkata, berperilaku, bertindak dengan jujur, dapat dipercaya, berkarakter, dan bertanggung jawab untuk mencapai tujuan organisasi.

2. Etos Kerja

Dalam etos kerja terkandung makna bahwa pegawai Kemenko PMK bekerja keras, optimis, produktif, inovatif, dan berdaya saing untuk mencapai tujuan organisasi.

3. Gotong Royong

Dalam gotong royong terkandung makna bahwa pegawai Kemenko PMK bekerja sama, setia kawan, toleran, saling menghargai, tolong menolong, dan peduli untuk mencapai tujuan organisasi.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

Untuk mencapai Visi, Misi, dan Tujuan sebagaimana telah diuraikan dalam Bab II, Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi, dan Kerangka Kelembagaan Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan Kemenko PMK mengacu pada Arah kebijakan dan Strategi sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2020-2024.

3.1 Agenda Pembangunan Nasional Bidang PMK

Berdasarkan tujuh agenda pembangunan nasional dalam RPJMN 2020-2024, seluruhnya terkait dengan bidang PMK. Keterkaitan Agenda Pembangunan Nasional dengan ruang lingkup koordinasi di bidang Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan dapat dilihat pada Tabel 3.1

Tabel 3.1: Agenda Pembangunan Bidang PMK (RPJMN 2020-2024)

NO.	AGENDA PEMBANGUNAN NASIONAL DALAM RPJMN 2020-2024	AGENDA PEMBANGUNAN NASIONAL BIDANG PMK DALAM RPJMN 2020-2024
1.	Penguatan ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas	Peningkatan SDM perekonomian (pertanian, kemaritiman, pariwisata, dll), riset dan teknologi
2.	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Pengembangan Kawasan strategis, PDT, kawasan perbatasan, dan perdesaan
3.	Meningkatkan SDM yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Pendidikan, Kesehatan, Kesejahteraan Sosial, serta Anak, Perempuan, dan Pemuda
4.	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Revolusi mental, Kebudayaan, Moderasi Beragama
5.	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Penyediaan air minum dan sanitasi

6.	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Pengurangan risiko dan penanggulangan bencana
7.	Memperkuat Stabilitas Polhukam dan Transformasi Pelayanan Publik	Rehabilitasi narkoba berbasis keluarga, Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan Perlindungan Pekerja Migran

Secara rinci, sasaran, target, arah kebijakan, dan strategi yang terkait dengan bidang peningkatan kualitas kesehatan dan pembangunan kependudukan.

3.1.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Agenda Pembangunan Ketiga – Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing. Ukuran keberhasilan yang ingin dicapai selama lima tahun ke depan dalam (1) pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan, dan (2) Pemenuhan pelayanan dasar ditunjukkan pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2: Sasaran, Indikator, dan Target Nasional - Agenda Pembangunan Ketiga

No.	Indikator	Baseline 2019	Target 2024
Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan			
1.	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate), [-]	2,28 (Supas, 2015)	2,10
2.	Cakupan NIK, [%]	96	100
	Kepemilikan akte kelahiran, [%]	83,3	100
	Pencatatan akte kematian, [%]	N.A	100
	Kepemilikan buku nikah, [%]	N.A	100
	Pencatatan perceraian, [%]	N.A	100
	Penyebab kematian, [-]	Belum Diterapkan	100
Pemenuhan layanan dasar			
1.	Angka kematian ibu, [per 100.000 kelahiran hidup]	305 (Supas, 2015)	183

No.	Indikator	Baseline 2019	Target 2024
2.	Angka kematian bayi, [per 1.000 kelahiran hidup]	24 (SDKI, 2017)	16
3.	Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi Cara Modern, [mCPR]	57,2 (SDKI, 2017)	63,4
4.	Unmet Need KB, [%]	10,6 (SDKI, 2017)	7,4
5.	ASFR 15-19 Tahun, [%]	36 (SDKI, 2017)	18
6.	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita, [%]	27,7 (Riskesdas, 2018)	14
7.	Prevalensi wasting (kurus dan sangat kurus) pada balita, [%]	10,2 (Riskesdas, 2018)	7
8.	Insidensi HIV, [per 1.000 penduduk yang tidak terinfeksi HIV]	0,24 (Kemkes, 2018)	0,18
9.	Insidensi TB, [per 100.000 penduduk]	319 (Global TB Report, 2017)	190
10.	Eliminasi malaria, [kab/kota]	285 (Kemkes, 2018)	405
11.	Persentase merokok penduduk usia 10-18 tahun, [%]	9,1 (Riskesdas, 2018)	8,7
12.	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥ 18 tahun, [%]	21,8 (Riskesdas, 2018)	21,8
13.	Persentase imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12-23 bulan, [%]	57,9 (Riskesdas, 2018)	90
14.	Persentase fasilitas kesehatan tingkat pertama terakreditasi, [%]	40 (Kemkes, 2018)	100
15.	Persentase rumah sakit terakreditasi, [%]	63 (Kemkes, 2018)	100
16.	Persentase puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar, [%]	23 (Kemkes, 2018)	83
17.	Persentase puskesmas tanpa dokter, [%]	12 (Kemkes, 2019)	0
18.	Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat esensial, [%]	86 (Kemkes, 2018)	96
19.	Persentase obat memenuhi syarat, [%]	78,6 (BPOM, 2019)	92,3
20.	Persentase makanan memenuhi syarat, [%]	76 (BPOM, 2019)	86

Arah kebijakan dan strategi nasional dalam pencapaian sasaran dan target Agenda Pembangunan Ketiga di lingkup PKKPK dapat dilihat pada Tabel 3.3.

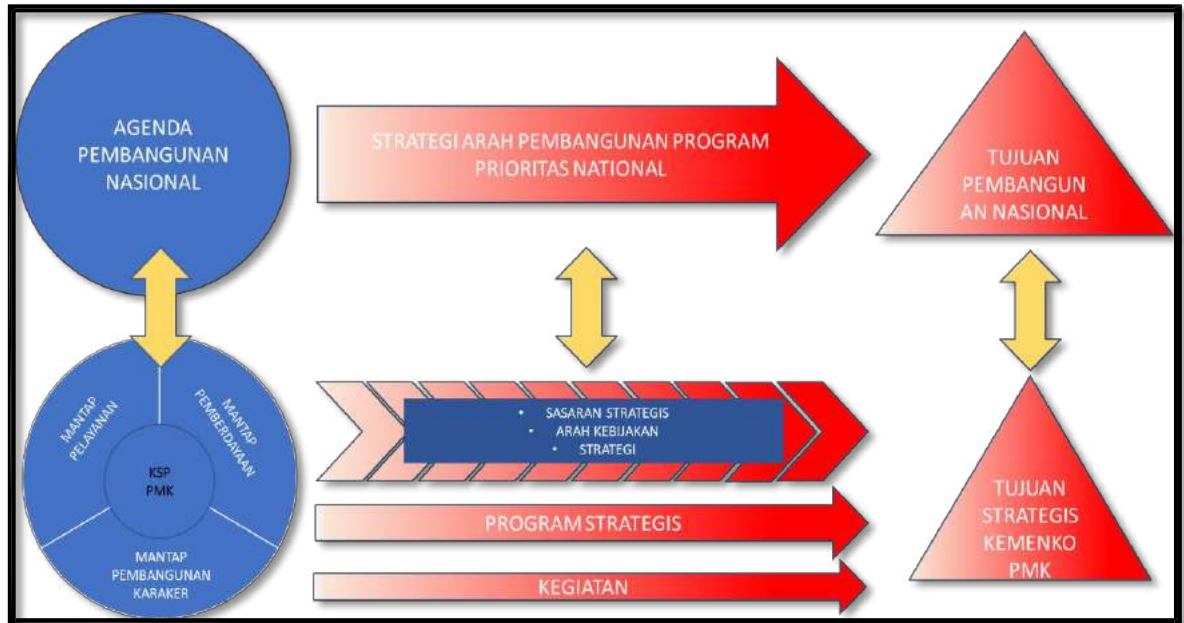
Tabel 3.3: Arah Kebijakan dan Strategi Nasional
Agenda Pembangunan Ketiga

No.	Arah Kebijakan	Strategi
1.	Mengendalikan pertumbuhan penduduk dan memperkuat tata kelola kependudukan	• Percepatan cakupan administrasi kependudukan; • Integrasi sistem administrasi kependudukan; • Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk.
2.	Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta	• Peningkatan kesehatan ibu, anak, keluarga berencana, dan kesehatan reproduksi; • Percepatan perbaikan gizi masyarakat; • Peningkatan pengendalian penyakit; • Pembudayaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat.
3.	Penguatan Sistem Kesehatan dan Pengawasan obat dan makanan	• Penguatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan; • Pemenuhan dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan; • Pemenuhan dan peningkatan daya saing sediaan farmasi dan alat kesehatan; • Peningkatan efektivitas pengawasan obat dan makanan; • Penguatan tatakelola pembiayaan penelitian dan pengembangan kesehatan.

3.1.1. Arah Kebijakan dan Strategi Kemenko PMK

Sebagai penjabaran dari strategi nasional, arah kebijakan, dan strategi Kemenko PMK mengacu pada tugas spesifik, yaitu menjadi lembaga koordinator pelaksanaan pembangunan manusia dan kebudayaan. Arah kebijakan dan strategi terutama ditujukan untuk penguatan fungsi KSP dalam perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan K/L terkait.

Gambar 3.1. Keterkaitan Antara Strategi Nasional dan Strategi Kemenko PMK



Arah Kebijakan Kemenko PMK merupakan upaya-upaya yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas, efektivitas, dan keberlanjutan dari peran, proses bisnis, teknologi dan kapasitas, serta sistem dalam lingkup PMK.

Tabel 3.4: Arah Kebijakan dan Strategi Kemenko PMK

SASARAN STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
SS-1: Meningkatnya Implementasi Kebijakan Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan Yang Maju Dan Berkelanjutan	Peningkatan efektivitas dan keberlanjutan pembangunan manusia dan kebudayaan	a. Meningkatkan komunikasi kelembagaan dalam koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan kebijakan yang terkait dengan isu-isu di bidang PMK; b. Meningkatkan keterlibatan K/L/D/M dalam koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan yang terkait dengan isu-

SASARAN STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
		isu di bidang PMK; c. Meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan pengendalian kebijakan yang terkait dengan isu-isu di bidang PMK; d. Memastikan pelaksanaan kebijakan PMK tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat.
SS-2: Meningkatkan Kualitas Koordinasi Dan Sinkronisasi Perumusan Dan Penetapan Kebijakan	Peningkatan kualitas proses penyusunan perumusan dan penetapan kebijakan	Meningkatkan kualitas perencanaan kebijakan melalui penetapan agenda setting dan formulasi kebijakan.
SS-3: Meningkatkan Kualitas Koordinasi Dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan	Peningkatan kualitas proses pelaksanaan kebijakan	Meningkatkan kualitas pelaksanaan kebijakan melalui implementasi dan evaluasi kebijakan
SS-4 : Meningkatkan Kualitas Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan	Peningkatan kualitas pengendalian pelaksanaan kebijakan	a. Meningkatkan kualitas identifikasi dan analisis risiko; b. Meningkatkan pengendalian risiko; c. Meningkatkan kualitas mitigasi.
SS-5: Meningkatkan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	a. Peningkatan kualitas, efektivitas dan keberlanjutan proses bisnis pelaksanaan percepatan reformasi birokrasi b. Peningkatan kapasitas SDM yang kreatif, inovatif, dan berdaya saing c. Peningkatan	a. Meningkatkan penataan manajemen perubahan; b. Meningkatkan penataan peraturan perundang-undangan; c. Meningkatkan penatalaksanaan penyusunan proses bisnis dan SOP organisasi; d. Meningkatkan penguatan

SASARAN STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
	pemanfaatan teknologi informasi dan pengelolaan big data yang relevan dalam rangka mendukung tugas fungsi organisasi yang efektif dan berkelanjutan	kelembagaan; e. Meningkatkan penataan manajemen SDM; f. Meningkatkan akuntabilitas kinerja; g. Meningkatkan pengawasan; h. Meningkatkan kualitas pelayanan publik; i. Meningkatkan kualitas program percepatan; j. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan SDM melalui pendidikan pelatihan yang berjenjang dan berkelanjutan; k. Meningkatkan sarana prasarana teknologi informasi; l. Memperkuat basis data terpadu; m. Meningkatkan kualitas manajemen data; n. Meningkatkan kualitas kelembagaan teknologi informasi
SS-6: Meningkatnya Kualitas Tatakelola Anggaran	Peningkatan sistem anggaran berbasis kinerja dan efektivitas pelaksanaan pengawasan internal	a. Meningkatkan kualitas sistem perencanaan dan penganggaran; b. Meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas pelaksanaan kegiatan dan anggaran; c. Memperkuat sistem pengawasan internal

3.1.2. Arah Kebijakan Deputy Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan

Arah Kebijakan Deputy Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan merupakan upaya-upaya yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas, efektivitas, dan keberlanjutan dari peran, proses bisnis, teknologi dan kapasitas, serta sistem dalam lingkup PMK.

Arah Kebijakan kemudian dijabarkan dalam berbagai strategi yang merupakan langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan Visi dan Misi. Selanjutnya, Tabel 3.5 memperlihatkan rincian dari Sasaran Strategis, Arah Kebijakan, dan Strategi Deputy Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan tahun 2020-2024.

Tabel 3.5: Arah Kebijakan dan Strategi

SASARAN STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
Tujuan 1: Terwujudnya Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan		
SS-1 Meningkatnya Implementasi Kebijakan Peningkatan Kualitas Kesehatan Dan Pembangunan Kependudukan (PKKPK)	Peningkatan efektivitas dan keberlanjutan pembangunan Kesehatan dan Kependudukan	a. Meningkatkan komunikasi kelembagaan dalam koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan kebijakan yang terkait dengan isu-isu di bidang Kesehatan dan Kependudukan; b. Meningkatkan keterlibatan K/L/D/M dalam koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan yang terkait dengan isu-isu di bidang Kesehatan dan Kependudukan; c. Meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan pengendalian kebijakan yang terkait dengan isu-

SASARAN STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
		isu di bidang Kesehatan dan Kependudukan; d. Memastikan pelaksanaan kebijakan Kesehatan dan Kependudukan tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat.
SS-2 Meningkatnya Kualitas Koordinasi Dan Sinkronisasi Perumusan Dan Penetapan Kebijakan PKKPK	Peningkatan kualitas proses penyusunan perumusan dan penetapan kebijakan	Meningkatkan kualitas perencanaan kebijakan melalui penetapan agenda setting dan formulasi kebijakan.
SS-3 Meningkatnya Kualitas Koordinasi Dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan PKKPK	Peningkatan kualitas proses pelaksanaan kebijakan	Meningkatkan kualitas pelaksanaan kebijakan melalui implementasi dan evaluasi kebijakan.
SS-4 Meningkatnya Kualitas Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan PKKPK	Peningkatan kualitas proses pengendalian kebijakan	Meningkatkan kualitas pengendalian kebijakan melalui implementasi dan evaluasi kebijakan.
Tujuan 2: Tercapainya birokrasi yang handal, terpercaya, dan akuntabel		
SS-5 Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	a. Peningkatan kualitas, efektivitas dan keber-lanjutan proses bisnis pelaksanaan percepatan reformasi birokrasi b. Peningkatan kapasitas SDM yang kreatif, inovatif, dan	a. Meningkatkan penataan manajemen perubahan; b. Meningkatkan penataan peraturan perundang- undangan; c. Meningkatkan penatalaksanaan penyusunan pro-ses bisnis dan SOP organisasi; d. Meningkatkan penguatan

SASARAN STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
	berdaya saing c. Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dan pengelolaan big data yang relevan dalam rangka mendukung tugas fungsi organisasi yang efektif dan berkelanjutan	kelembagaan; e. Meningkatkan penataan manajemen SDM berbasis sistem merit; f. Meningkatkan akuntabilitas kinerja; g. Meningkatkan pengawasan; h. Meningkatkan kualitas pelayanan publik; i. Meningkatkan kualitas program percepatan; j. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan SDM melalui pendidikan pelatihan yang berjenjang dan berkelanjutan; k. Meningkatkan sarana prasarana teknologi informasi; l. Memperkuat basis data terpadu; m. Meningkatkan kualitas manajemen data; n. Meningkatkan kualitas kelembagaan teknologi informasi

3.1.3. Fokus Kebijakan Strategis Koordinasi

Untuk mempermudah proses KSP, Kemenko PMK mengelompokkan secara garis besar lima fokus koordinasi program dan kegiatan yang dilakukan K/L serta masyarakat dalam pembangunan nasional bidang PMK, yaitu (1) Selaras Basis Data, (2) Jaminan Kebutuhan dan Pelayanan Dasar, (3) Pemberdayaan Masyarakat, (4) Pembangunan Manusia Berkarakter, dan (5) Pembangunan Desa Semesta.

Kelima fokus koordinasi tersebut dimaksudkan untuk memudahkan KSP di bidang PMK yang terkait dengan K/L dan menjadi

tugas dan fungsi Kedeputian agar memudahkan, mengefisienkan, dan mengefektifkan pencapaian pembangunan sebagaimana yang termaktub dalam agenda pembangunan nasional. Berikut titik-titik pusat koordinasi:

Gambar 3.1. Lima Fokus Koordinasi Kemenko PMK



Fokus pertama, yaitu fokus koordinasi pada Selaras Basis Data adalah upaya Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan memusatkan titik koordinasi pada penggalangan seluruh data dan informasi yang terkait dan berperan dalam kerangka PMK, yang tersedia dan tersebar atau dimiliki oleh K/L terkait. Penggalangan keseluruhan data dan informasi tersebut dimaksudkan untuk menyusun keselarasan, kesamaan suatu basis data yang menyatu, terintegrasi, dan memudahkan proses pengambilan keputusan. Penggalangan keseluruhan data dan informasi juga dimaksudkan untuk memperoleh data dan informasi yang bersifat terverifikasi, valid (terpercaya), reliable (andal), dan disepakati sebagai data dan informasi bersama. Keberhasilan Fokus koordinasi yang pertama, akan memberikan kemudahan bagi K/L yang terkait dalam mengambil keputusan dan kebijakan, sekaligus memudahkan koordinasi,

verifikasi, efektivitas, dan efisiensi dalam mewujudkan pencapaian tujuan PMK.

Fokus kedua, yaitu Jaminan Kebutuhan dan Pelayanan Dasar adalah upaya Deputy Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan memusatkan titik koordinasi pada terpenuhinya dan terfasilitasinya bidang-bidang pemenuhan kebutuhan dan pelayanan dasar manusia dan masyarakat Indonesia. Pemenuhan dan pelayanan kebutuhan dasar adalah keseluruhan kerangka pembangunan yang terkait dengan keberhasilan Pembangunan Kesehatan dan Kependudukan. Keberhasilan fokus koordinasi akan mempermudah tercapainya manusia Indonesia yang berkualitas serta semakin meningkatnya ketenteraman masyarakat sebagai wujud dirasakannya kehadiran negara dalam memfasilitasi kebutuhan dan memecahkan masalah warganya. Fokus jaminan kebutuhan dan pelayanan dasar meliputi: a) Pendidikan, b) Kesehatan, c) Pekerjaan Umum, d) Penataan Ruang, e) Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, f) Ketenteraman, g) Ketertiban Umum, h) Perlindungan Masyarakat, i) Sosial, j) Identitas, dan k) Infrastruktur Dasar (Air Bersih dan Sanitasi).

Fokus ketiga, yaitu fokus koordinasi dalam Pemberdayaan Masyarakat, adalah upaya Deputy Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan, Kemenko PMK memusatkan titik koordinasi pada daya dan upaya memunculkan, memfasilitasi potensi, serta keberdayaan masyarakat Indonesia. Pengembangan potensi dan keberdayaan masyarakat Indonesia adalah semua kerangka pembangunan dalam peningkatan peranan perempuan, pemuda, keluarga dalam konteks kontribusinya pada pemecahan-pemecahan masalah diri sendiri, kelompok, dan/atau komunitas maupun partisipasinya dalam pembangunan dalam makna yang luas. Potensi dan keberdayaan juga dimaknai dalam upaya meningkatkan kapasitas inovasi dan penguasaan teknologi untuk meningkatkan daya saing. Keberhasilan fokus koordinasi ini akan memudahkan pencapaian berupa tumbuhnya

kepercayaan masyarakat pada Pemerintah dan meningkatnya produktivitas rakyat, daya saing, dan kemajuan bangsa

Fokus keempat, yaitu fokus koordinasi dalam Pembangunan Manusia Berkarakter adalah upaya Deputy Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan, Kemenko PMK dalam memusatkan titik koordinasi pada kerangka revolusi mental, dalam pembangunan kesehatan dan Kependudukan. Fokus keempat juga dimaksudkan untuk memfasilitasi kelestarian budaya lokal yang genuine (asli), kelembagaan sosial sehingga dapat berperan dan berkontribusi bagi penguatan keseluruhan karakter manusia dan bangsa Indonesia. Keberhasilan fokus koordinasi ini akan memudahkan pencapaian pembangunan dalam rangka merevolusi karakter bangsa serta memperteguh kebhinnekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Fokus kelima, yaitu fokus koordinasi dalam Pembangunan Desa secara keseluruhan atau Desa Semesta. Koordinasi dalam Pembangunan desa adalah upaya Deputy Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan, Kemenko PMK memusatkan titik koordinasi untuk memfasilitasi percepatan pembangunan perdesaan yang bermartabat, memperkuat pembangunan daerah berlandaskan desentralisasi asimetris, serta upaya-upaya mengurangi jarak atau ketimpangan antar kelompok ekonomi masyarakat. Fokus koordinasi pembangunan desa berupaya untuk memfasilitasi K/L yang terlibat dalam pembangunan fisik dan nonfisik perdesaan akan bersatu padu, terintegrasi, dan terkoordinasi dalam mewujudkan daerah dan desa yang sejahtera di mana masyarakatnya hidup harmoni, adil, dan makmur. Keberhasilan koordinasi kelima ini akan memudahkan pencapaian pembangunan Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Terfasilitasinya pembangunan desa akan memperkuat nilai-nilai nasionalisme sebagai bagian dari NKRI.

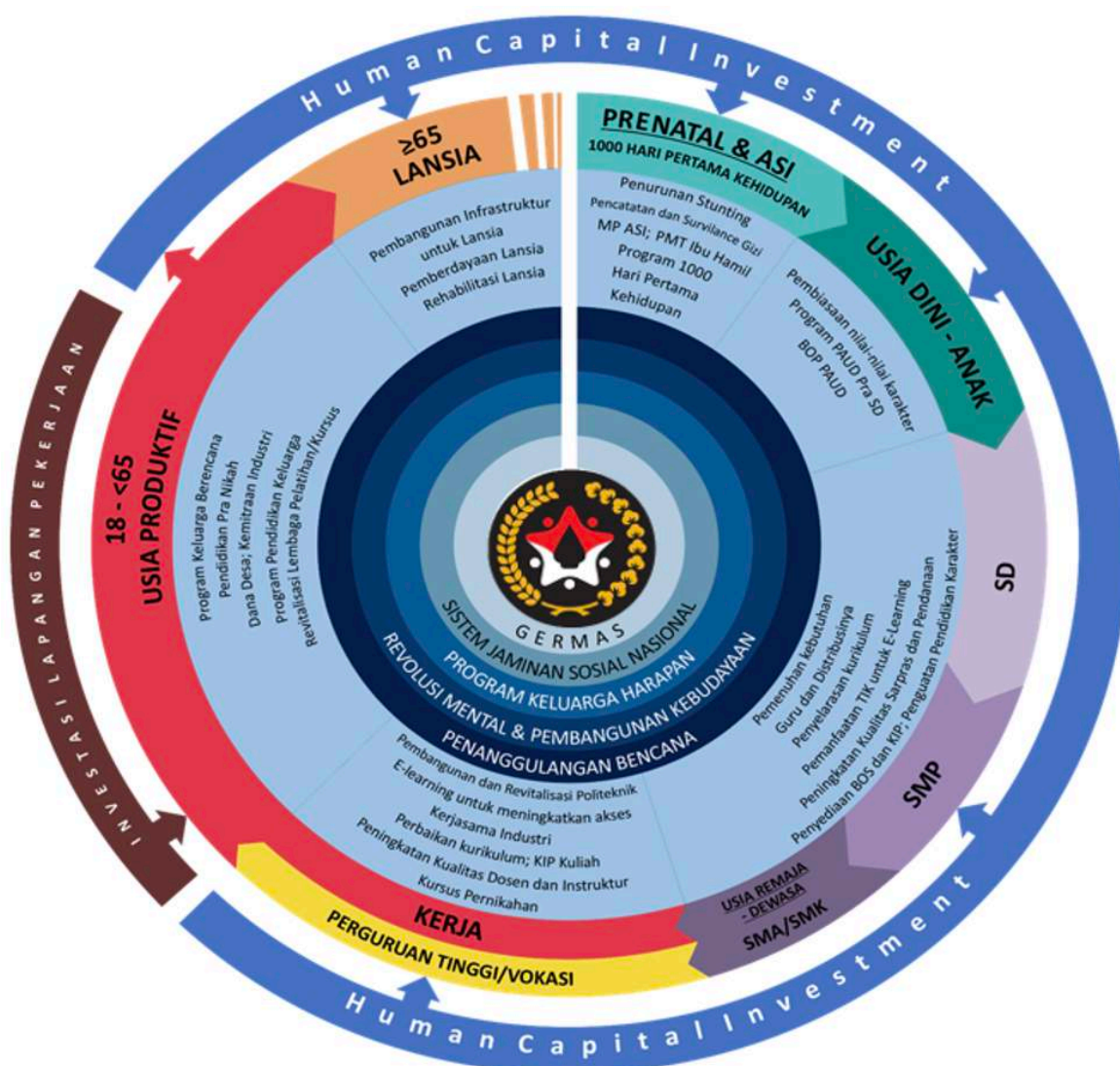
3.1.4. Strategi Kemenko PMK dalam Perspektif Manusia Sebagai Modal Pembangunan

Manusia sebagai modal utama pembangunan, perlunya investasi berkelanjutan pada pembangunan manusia serta penciptaan kebudayaan modern. Manusia sebagai modal pembangunan dan kebudayaan modern menjadi prasyarat utama tercapainya Visi Nasional, yaitu Indonesia Maju.

Manusia dapat juga dilihat dari sudut pandang lain, yaitu sebagai suatu rangkaian proses kehidupan dari kelahiran, masa anak-anak, remaja, dewasa, dan lanjut usia (lansia). Bila melihat rangkaian proses kehidupan manusia, proses pembangunan manusia dan kebudayaan sudah seyogyanya menyentuh semua tahapan proses – dari lahir sampai lansia. Dengan demikian, fokus KSP yang dilakukan melalui Trimantap diarahkan untuk menjamin terwujudnya kualitas manusia Indonesia yang unggul dengan melakukan intervensi program dan kebijakan dari mulai prenatal sampai dengan lansia.

Gambar 3.2 memperlihatkan arah kebijakan dan program PMK menggunakan perspektif proses kehidupan manusia yang dikenal dengan Siklus Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Siklus PMK, di mana investasi manusia telah menyentuh seluruh fase dan aspek kehidupan manusia.

Gambar 3.2. Siklus Peran dan Visi dan Misi Kemenko PMK

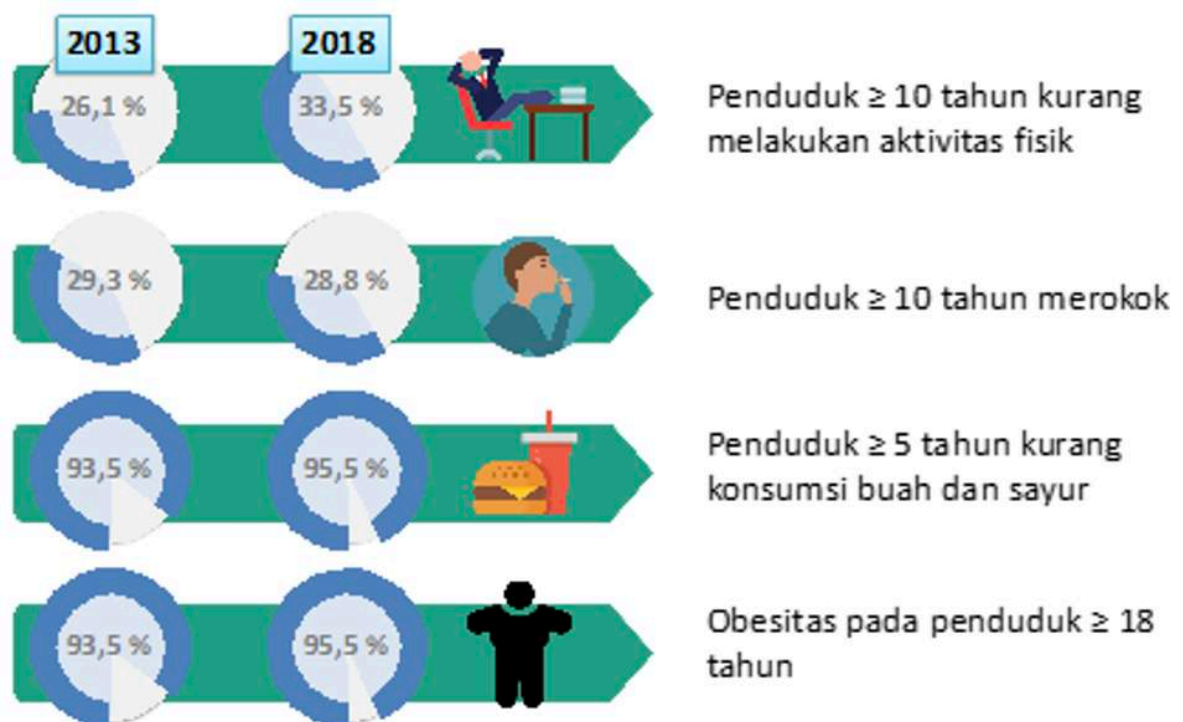


Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas, dari dimensi kesehatan pada RPJMN 2020-2024 fokus untuk Meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta terutama penguatan pelayanan kesehatan dasar (Primary Health Care) dengan mendorong peningkatan upaya promotif dan preventif, didukung inovasi dan pemanfaatan teknologi, melalui: 1) Peningkatan kesehatan ibu, anak, keluarga berencana (KB) dan kesehatan reproduksi, 2) Percepatan perbaikan gizi masyarakat, 3) Peningkatan pengendalian penyakit, 4) Pembudayaan perilaku hidup sehat melalui Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, 5) Penguatan sistem kesehatan dan pengawasan obat dan makanan. Masih banyak hal yang harus ditingkatkan, antara lain:

- (1) Kesehatan Ibu, Anak, Keluarga Berencana (KB) dan Kesehatan Reproduksi.

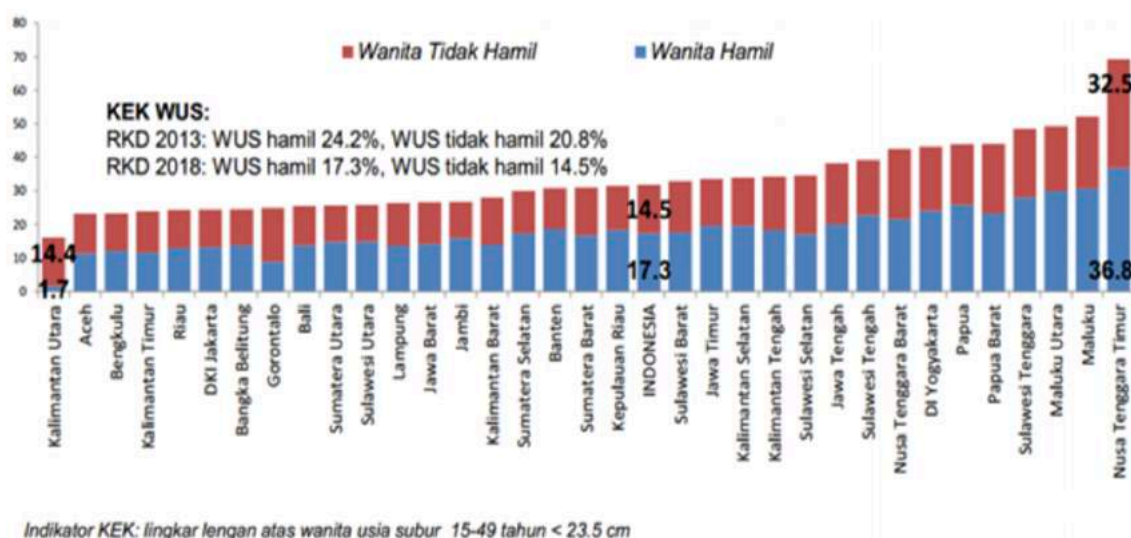
Berdasarkan data Riskesdas tahun 2018 angka proporsi usia dewasa yang mengalami obesitas meningkat menjadi 21,8% disertai dengan peningkatan kejadian hipertensi menjadi 34,1%. Anak-anak dan remaja dalam rentang usia 10 – 18 tahun yang merokok sebanyak 9,1% dan penduduk dengan aktivitas fisik kurang juga meningkat dari tahun sebelumnya menjadi 33,5%. Selain itu, dari segi konsumsi serat penduduk Indonesia masih rendah, sebanyak 95,5% penduduk masih belum mengonsumsi sayur dan buah sesuai dengan anjuran.

Gambar 3.3. Data Riskesdas tahun 2018



Pemerintah Indonesia sedang menghadapi Bonus Demografi Penduduk dalam mencapai Generasi Emas di tahun 2045. Pada periode tahun 2020 – 2045, 70% dari jumlah penduduk Indonesia berada dalam usia produktif (15 – 64 tahun) dan 30% dari penduduk (<15 tahun, >64 tahun) merupakan penduduk tidak produktif. Pemerintah telah membuat berbagai rancangan kebijakan yang disiapkan untuk menghadapi bonus demografi, salah satunya perbaikan gizi masyarakat.

Gambar 3.4. Proporsi Resiko Kurang Energi Kronis pada Wanita Usia Subur menurut Provinsi Tahun 2018



Obesitas sebagai salah satu permasalahan gizi masyarakat harus mendapatkan perhatian khusus. Kelebihan berat badan dapat menjadi faktor utama penyebab meningkatnya prevalensi Penyakit Tidak Menular (PTM) atau penyakit degeneratif.

Upaya preventif dan promotif merupakan langkah yang tepat untuk mengurangi angka mortalitas dan morbiditas yang disebabkan oleh penyakit menular dan penyakit tidak menular. Promosi kesehatan hendaknya dapat berjalan secara integral dengan berbagai aktivitas pembangunan kesehatan sehingga menjadi arus utama pada percepatan pencapaian SDGs dan mewujudkan jaminan kesehatan masyarakat. Oleh karena itu dikeluarkan Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) untuk mendorong seluruh lintas sektor dan sektor swasta agar berperan aktif dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat Indonesia.

Kesehatan Ibu dan Anak termasuk ke dalam Goal Ke-3 dari SDG's dan pada tahun 2030, dunia mendorong untuk tercapainya target penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dibawah 70 per 100.000 kelahiran hidup, dan Angka Kematian Bayi dan Balita proporsinya ditargetkan turun hingga 12 per 1.000 kelahiran hidup.

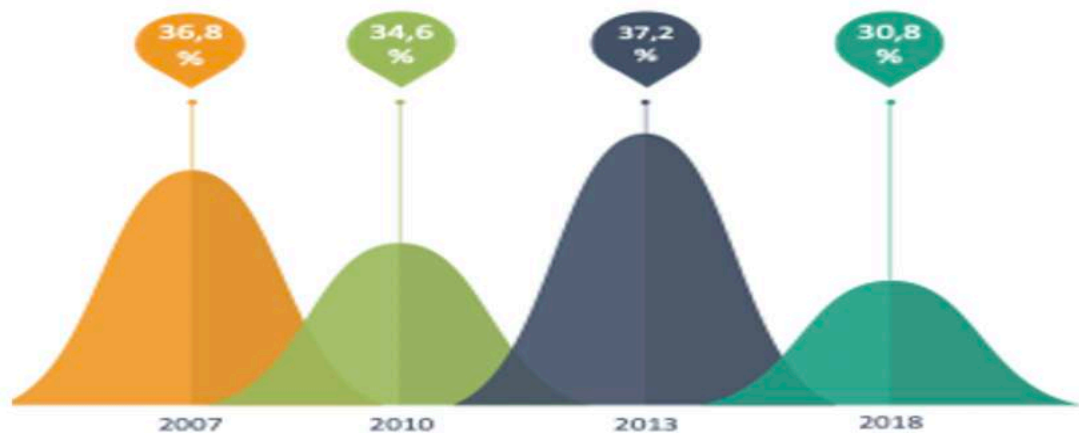
Di Indonesia sendiri, Angka Kematian Ibu menurut data Supas 2015 masih tinggi yaitu 305/100.000 KH dan untuk Angka Kematian Bayi pada tahun 2017 sebesar 24/1.000 KH. Hal ini mendeskripsikan bahwa jaminan kesehatan untuk ibu dan balita masih sangat kurang dari segi kualitas dan kuantitasnya.

Berdasarkan Riskesdas 2018, Indonesia masih memiliki permasalahan yang besar pada kesehatan Ibu dan Wanita Usia Subur (WUS). Proporsi Kurang Energi Kronis pada WUS mengalami penurunan dari 24,2% (2013) menjadi 17,3% (2018). Walaupun terjadi penurunan, namun angka ini masih termasuk tinggi dan diiringi juga dengan peningkatan proporsi anemia pada ibu hamil, dari 37,1% (2013) menjadi 48,9% (2018).

Upaya perbaikan gizi dengan fokus pada pencegahan stunting dilakukan bersama dengan berbagai pemangku kepentingan, antara lain kader kesehatan, kader pembangunan manusia, kader KB, PKK, dunia usaha, kelompok masyarakat madani, perguruan tinggi, media masa, organisasi profesi, kelompok keagamaan, dan mitra pembangunan yang lain.

Pada tahun 2019 telah dilakukan koordinasi intervensi pencegahan stunting di lokus fokus pada 160 kabupaten/kota dengan 1600 Desa. Sedangkan pada tahun 2020 lokus stunting ditingkatkan menjadi 260 kabupaten/kota dengan desa lokus yang ditetapkan oleh masing-masing Provinsi. Hingga tahun 2019 telah terjadi penurunan prevalensi stunting berdasarkan data Riskedas yaitu, 37,2% (2013), 30,8% (2018) dan 27,6% (2019) menurut data SSGBI. Berdasarkan data Riskedas 2018 dan SSGBI 2019 terdapat penurunan prevalensi gizi kurang pada balita dari 17,7% (2018) menjadi 16,2% (2019). Selain itu balita wasting juga terjadi penurunan prevalensi dari 10,2% (2018) menjadi 7,4% (2019).

Gambar 3.5. Prevalensi Balita Stunting Tahun 2017 – 2018 (Riskesdas)



Stunting disebabkan oleh Faktor Multi Dimensi terutama pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) yaitu mulai dari janin hingga balita. Adapun faktor-faktor tersebut adalah praktek pengasuhan yang kurang maksimal, minimnya pengetahuan tentang kesehatan dan gizi sebelum dan pada masa kehamilan, ASI eksklusif yang tidak terlaksana dengan baik, pemberian MP-ASI yang tidak sesuai dengan usia dan kebutuhan gizi bayi, terbatasnya layanan kesehatan termasuk layanan ANC-Ante Natal Care, Post Natal, remaja putri dan ibu hamil belum mengkonsumsi suplemen zat besi yang memadai, menurunnya tingkat kehadiran anak di Posyandu, tidak mendapat akses yang memadai ke layanan imunisasi, kurangnya akses ke makanan bergizi, serta akses ke air bersih dan sanitasi yang masih terbatas.

Gambar 3.6. Strategi 5 Pilar Penanganan Stunting



Intervensi gizi spesifik dan sensitif merupakan upaya pemerintah untuk mempercepat pencegahan stunting. Pendekatan ini melibatkan berbagai sektor baik pemerintah maupun non pemerintah, sehingga pelaksanaannya tidak hanya berupa kesehatan.

Upaya promotif dapat dilakukan dengan kampanye diberbagai media cetak maupun elektronik dengan pola komunikasi yang menjangkau semua pihak. Materi stunting juga dapat diberikan pada materi pembelajaran sekolah agar dapat mengedukasi remaja dampak kekurangan gizi. Dari segi preventif, pemerintah telah mecanangkan 1000 hari pertama kehidupan, melalui kebijakan ini diharapkan setiap kebijakan pemerintah, para pelaku industri, dan juga masyarakat dapat mendukung intervensi kesehatan pada setiap siklus umur mulai dari remaja, hamil, melahirkan dan menyusui hingga memasuki masa remaja lagi.

(2) Pengendalian Penyakit

Saat ini Indonesia mengalami triple burden penyakit, yaitu terjadinya peningkatan penyakit tidak menular sementara penyakit menular masih menjadi beban di masyarakat serta munculnya penyakit baru atau emerging diseases (new emerging and re emerging) berpotensi wabah.

Indonesia juga berhadapan dengan Pandemi COVID-19 yang terdeteksi pada maret 2020, sampai dengan September 2020 penularan COVID19 masih terus terjadi bahkan semakin cepat, per 8 September 2020 tercatat lebih dari 200 ribu kasus yang tersebar di seluruh provinsi. Dari 8.230 korban jiwa COVID19 yang dilaporkan, ada 600 dengan catatan komorbid, 178 dari 600 kematian penderita COVID19 dengan komorbid penyakit, atau 29,6% kematian COVID19 dengan komorbid berkaitan dengan perilaku merokok yaitu: kanker, asma, gangguan napas, penyakit paru obstruksi kronis dan jantung.

Pada tahun 2019, diestimasikan bahwa di Indonesia terdapat 845.000 kasus TBC atau 319 per 100.000 penduduk dengan angka kematian sebesar 107.000 atau 40 per 100.000 penduduk. Untuk TBC-

HIV sebesar 36.000 kasus per tahun atau 14 per 100.000 penduduk dengan kematian sebesar 9.400 atau 3,6 per 100.000 penduduk.

Notifikasi kasus TBC mengalami peningkatan yang signifikan sejak tahun 2017, akan tetapi diperkirakan bahwa sebesar 33% kasus masih belum dilaporkan dan angka keberhasilan pengobatan masih berada di angka 83% serta terdapat 11.463 kasus TBC resisten obat (TBC RO).

Sesuai dengan komitmen global, pemerintah Indonesia juga berkomitmen untuk mencapai Eliminasi TBC di tahun 2030. Berbagai upaya dan strategi telah dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Sesuai dengan target RPJMN 2020-2024, Pemerintah menargetkan untuk dapat menurunkan insidens kasus TBC sampai di angka 190 per 100.000 penduduk dan menurunkan angka kematian menjadi 27 per 100.000 penduduk. Selain itu, ditargetkan 90% pasien TBC dewasa, 90% pasien TBC anak, dan 90% pasien TBC RO dapat ditemukan dan diobati.

Sebagaimana disebutkan di atas, bahwa Indonesia mengalami peningkatan penyakit tidak menular. Berdasarkan data WHO, 66% penyebab kematian di Indonesia adalah penyakit tidak menular. Angka ini terdiri dari penyakit kardiovaskuler (37%), Kanker (13%), PTM lain (10%), dan diabetes sebesar 6%. Penyakit tidak menular disebabkan oleh berbagai faktor yang saling berkaitan.

Adapun faktor risiko utama meliputi diet tidak sehat, kurang aktivitas fisik, konsumsi rokok, alkohol serta polusi udara. Rokok sesungguhnya tidak hanya merupakan faktor risiko penyakit tidak menular yang lebih banyak menyerang orang dewasa, namun juga mengganggu perkembangan janin dan anak-anak.

Bahaya merokok diperparah juga dengan usia konsumsi pertama kali yang cukup muda. Hasil Riskesdas 2018 menunjukkan prevalensi merokok di bawah usia 10-18 th adalah 9,1 dan 22 dari 100 remaja usia 15-19 tahun telah merokok. Sementara itu, hasil Global Youth Tobacco Survey (GYTS) tahun 2019 menyatakan 18,8% pelajar usia 13-15 tahun merokok dan 57,8% pelajar usia 13-15 tahun terpapar asap rokok di rumah.

Berdasarkan hasil riset kesehatan dasar tahun 2013 dan 2018, diketahui telah terjadi peningkatan perokok pemula usia 10-18 tahun dari 7,2% pada tahun 2013 menjadi 9,1% pada tahun 2018. Proporsi perokok remaja usia 15-19 th juga meningkat dari 12,7% pada tahun 2001 menjadi 23,1%.

Pusat Kajian Jaminan Sosial Universitas Indonesia menyatakan bahwa anak yang orang tuanya merokok memiliki BB lebih rendah 1,5 kg dan lebih pendek 0,34 cm bila dibandingkan anak yang orang tuanya tidak merokok. Kemungkinan terjadi stunting pada keluarga yang merokok adalah 5,5%. Fakta lain yang juga dikemukakan dalam kajian tersebut bahwa penerima Program Keluarga Harapan (PKH) memiliki pengeluaran rokok Rp.3.660/kapita per minggu dan 3,5 batang/kapita per minggu lebih tinggi jika dibandingkan dengan bukan penerima PKH.

Tabel 3.6. Sepuluh peringkat teratas dan beban penyakit (Disability Adjusted Life Years / DALYs) pada 2017 di Indonesia dan keterkaitannya dengan hasil RISKESDAS 2018

No.	Beban Penyakit	Masalah	Prevalensi (Riskesdas 2018)	Sebaran Daerah Prev Tertinggi
1	Stroke	PTM	10,9 ‰	Kaltim (14,7), DIY (14,6), Sulut (14,2), Kepri (12,9), Kalsel (12,7)
2	Penyakit jantung iskemik	PTM	1,5%	Kaltara (2,2), DIY (2,0), Gorontalo (2,0), DKI Jakarta (1,9), Kaltim (1,9)
3	Diabetes	PTM	2%	DKI Jakarta (3,4), DIY (3,1), Kaltim (3,1), Sulut (3,0), Jatim (2,6)
4	Gangguan neonatal	KIA & gizi	N/A	N/A
5	Tuberculosis	PM	0,42%	Papua (0,77), Banten (0,76), Papua Barat (0,53), Sumsel (0,53)
6	Sirosis	PTM - PM	0,39% (hepatitis)	Papua (0,66), Sulteng (0,62), Sulbar (0,57), NTB (0,56), Gorontalo (0,55)
			0,8% (konsumsi minuman)	NTT (3,2), Bali (2,9), Sulut (2,4), Maluku (2,4), Papua Barat (2,3)

			beralkohol yang berbahaya)	
7	Diare	PM	6,8%	Bengkulu (8,9), Aceh (8,5), NTB (8,4), Sumbar (8,3), Sumut (8,1)
8	Nyeri punggung bawah	PTM	7% (penyakit sendi)	Aceh (13,26), Bengkulu (12,11), Bali (10,46), Papua (10,43), Kalbar (9,57)
9	PPOK	PTM	24,3% (merokok setiap hari)	Lampung (28,1), Bengkulu (27,8), Gorontalo (27,4), Jabar (27,1), Sumbar (26,9)
10	Cedera	PTM	9,2% (cedera yang mengganggu aktivitas sehari-hari)	Sulteng (11,3%), Papua Barat (12,6%), Sulut (11,6%), Sultra (11,3%), Banten (11,1%)
11	Depresi	PTM	6,1%	Sulteng (12,3%), Gorontalo (10,3%), NTT (9,7%), Maluku (9,3%), NTB (8,8%)

Melihat tren beban kesehatan diatas dan terus meningkatnya prevalensi merokok pada anak atau semakin muda nya usia coba merokok, akan menimbulkan kecenderungan kejadian PTM meningkat pada usia muda dan saat indonesia mengalami bonus demografi, sehingga juga beriringan dengan meningkatnya beban kesehatan dan berkurangnya produktifitas angkatan kerja akibat sakit PTM.

Ancaman lain bagi pembangunan sumber daya manusia Indonesia yang memiliki proporsi usia muda cukup tinggi adalah penyalahgunaan NAPZA. Melihat proyeksi perkembangan penduduk telah diprediksi dalam 10-20 tahun kedepan atau lebih cepat, Indonesia akan mendapatkan bonus demografi. Bonus demografi dicirikan dengan besarnya jumlah angkatan kerja, sehingga pergerakan ekonomi dan tabungan nasional saat itu akan tinggi. Bonus demografi akan terjadi apabila pemuda Indonesia memiliki keunggulan sehingga mampu bersaing atau memiliki posisi tawar dari sisi kinerja yang baik, untuk itulah mempersiapkannya perlu dilakukan sejak masa kandungan sampai dengan usia anak sekolah dan kuliah.

Data korban penyalahguna NAPZA hasil penelitian BNN dan Puslitkes UI, prevalensi penyalahguna narkoba (umur 10 – 59 tahun) diproyeksikan meningkat tiap tahun yaitu 1.99% (3.6 – 3.8 juta) pada tahun 2008 menjadi 2.8% (5.1 juta) pada tahun 2015. Untuk menjawab tantangan pembangunan tersebut, sekaligus menyelamatkan generasi muda dari dampak buruk penyalahgunaan NAPZA, maka diperlukan upaya mengurangi suplai NAPZA melalui langkah pemberantasan dan mengurangi demand NAPZA melalui langkah pencegahan dan rehabilitasi.

(3) Pelayanan Kesehatan

(3.1) Layanan Kesehatan Primer.

Selama periode 2014-2018, tercatat pertumbuhan jumlah puskesmas di Indonesia meningkat dari jumlah 9.731 di tahun 2014 menjadi 9.993 pada tahun 2018, sehingga terjadi peningkatan sebesar 2,7%. Rasio puskesmas per kecamatan secara nasional adalah 1,39 artinya dalam 1 kecamatan, terdapat 1,39 puskesmas. Sampai dengan akhir tahun 2018 sebanyak 75,32 % puskesmas telah terakreditasi, sedangkan untuk klinik yang terakreditasi jumlahnya baru 14 yang tercatat oleh komisi akreditasi FKTP per Tahun 2019. Untuk peningkatan mutu pelayanan kesehatan, masih diperlukan upaya keras untuk meningkatkan cakupan dan tingkatan akreditasi FKTP (puskesmas dan klinik), sehingga target FKTP terakreditasi bisa mencapai 100 % di tahun 2024.

(3.2) Layanan Kesehatan Sekunder dan Tersier.

Untuk layanan kesehatan sekunder dan tersier di FKRTL, sampai dengan tahun 2018, tercatat 2.813 RS di Indonesia dengan sebaran 50,4 % berada di pulau jawa dan sisanya tersebar di daerah lain. Berdasarkan profil kesehatan Indonesia tahun 2018, sebanyak 1.970 (70%) telah terakreditasi, sehingga berdasarkan target capaian RPJMN 2020-2024, persentase RS terakreditasi yaitu 100%. Dari jumlah RS di Indonesia, terdapat 144 RS Rujukan yang terdiri dari 14 RS Rujukan Nasional, 20 RS Rujukan Provinsi dan 110 RS Rujukan Regional yang perlu terus dikembangkan dan ditingkatkan kualitas pelayanannya

(3.3) Sumber daya manusia kesehatan.

Berdasarkan data per 31 Desember 2018 dari Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan, terdapat 2.319 atau 23 % puskesmas yang telah memiliki 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar. Terdapat 1.513 puskesmas atau 15 % yang sama sekali tidak memiliki dokter, yang sebarannya masih di dominasi oleh Indonesia timur yaitu Provinsi Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat.

Untuk rasio dokter berbanding puskesmas mengalami kenaikan dari 1,99 (Risfaskes 2011) menjadi 2,08 dokter per puskesmas (Risnakes, 2017). Rasio dokter per puskesmas mengalami peningkatan di sebagian besar wilayah barat Indonesia dan mengalami penurunan di wilayah timur Indonesia. Dalam lima tahun ke depan, penempatan tenaga dengan skema khusus dapat dilanjutkan dan diperkuat melalui inovasi yang tepat, khususnya untuk daerah DTPK.

Untuk peningkatan mutu pelayanan kesehatan, program pelatihan SDM kesehatan menjadi sangat penting. Peningkatan keterampilan di bidang klinik melalui on-job training (magang) dan peningkatan kemampuan bidang manajerial untuk para kepala puskesmas dan dinas kesehatan melalui berbagai pelatihan perlu dipertimbangkan dan diperkuat.

(3.4) Pembiayaan Kesehatan.

Dalam rangka mencapai cakupan kesehatan semesta (Universal Health Coverage/UHC), dibutuhkan kombinasi antara kecukupan fasyankes dan cakupan kepesertaan JKN. Pembiayaan JKN di Indonesia diperlukan untuk menjamin akses pada upaya kesehatan perorangan, namun tidak tepat untuk membiayai berbagai macam intervensi kesehatan masyarakat.

Intervensi kesehatan masyarakat atau UKM adalah public goods sehingga pembiayaannya tidak melalui mekanisme tarif dan mekanisme asuransi kesehatan. Pembiayaan UKM menjadi tanggung jawab pemerintah, baik melalui APBN dan atau APBD. Perlu ada jaminan pembiayaan kesehatan di APBN dan APBD serta ada keseimbangan pembiayaan yang memadai untuk UKP dan UKM.

(3.5) Sediaan farmasi dan alat kesehatan.

Dalam rangka memenuhi sediaan farmasi dan alat kesehatan, pemerintah pusat harus memastikan bahwa pasokan obat program kesehatan dan stok penyangga (buffer stock) memadai, serta memastikan keamanan, efikasi dan kualitasnya. Secara keseluruhan, kondisi ketersediaan obat dan vaksin di puskesmas telah mengalami peningkatan secara signifikan, dari 79,38% di tahun 2015 menjadi 94,22% di tahun 2019. Namun demikian, tantangan yang dihadapi adalah disparitas ketersediaan obat dan alkes antar daerah, terutama di DTPK, serta ketersediaan antar tingkat pelayanan kesehatan.

Disamping itu, kemandirian produk farmasi dan alkes dalam negeri belum tercapai, karena lebih dari 90% bahan baku obat adalah produk impor. Tantangan yang dihadapi untuk kemandirian produk farmasi adalah ekosistem yang kurang mendukung kemandirian dan daya saing industri dalam negeri.

(4) Kependudukan dan Keluarga Berencana

Penggunaan kontrasepsi (Contraceptive Prevalence Rate/CPR) cara modern menurun dari 57,9 persen (SDKI 2012) menjadi 57,2 persen (SDKI 2017). Angka kelahiran (Age Specific Fertility Rate/ASFR) umur 15-19 tahun walaupun turun cukup signifikan dari 48 (SDKI, 2012) menjadi 36 (SDKI, 2017), tetapi masih tinggi dan ada indikasi tindakan aborsi di kalangan remaja. Hal ini disebabkan rendahnya pemahaman remaja tentang kesehatan reproduksi dan masih tingginya angka perkawinan anak serta penyiapan kehidupan berkeluarga yang masih belum optimal.

Pemahaman orangtua mengenai pola asuh yang baik, kesehatan lingkungan serta kemampuan menyediakan gizi yang cukup juga masih rendah sehingga prevalensi stunting masih tinggi.

Penduduk tumbuh seimbang merupakan salah satu prasyarat untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia. Hal ini dapat diwujudkan melalui pengendalian kuantitas, peningkatan kualitas dan pengarahan mobilitas penduduk. Dengan penduduk tumbuh seimbang, daya tampung dan daya dukung lingkungan dapat tetap terjaga. Hal ini dapat dicapai salah satunya dengan menurunkan rata-

rata angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) nasional sampai pada tingkat replacement rate yaitu 2,1.

Laju pertumbuhan penduduk telah menurun dari 1,49 persen (SP 2010) menjadi 1,43 persen (Supas 2015). Namun, jumlah penduduk secara absolut meningkat dari 237,6 juta pada tahun 2010 menjadi 255,2 juta di tahun 2015, di mana lebih dari 60 persennya merupakan penduduk usia produktif (usia 15-64 tahun).

Oleh karena itu, Deputy Bidang Koordinasi PKKPK dalam melaksanakan tugas dan fungsinya direpresentasikan oleh 4 (empat) Asisten Deputy, dan 1 (satu) Sekretariat Deputy yang saling terkait satu dengan lainnya untuk meningkatkan kualitas kesehatan dan pembangunan kependudukan dengan pendekatan siklus hidup melalui KSP. Adapun keasdepan tersebut adalah:

1. Asisten Deputy Ketahanan Gizi Dan Promosi Kesehatan, melakukan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian (KSP) kebijakan dan penyusunan RAK (Rumusan Alternatif Kebijakan) terkait Ketahanan Gizi Dan Promosi Kesehatan.

Korelasi terhadap siklus peran Kemenko PMK adalah menciptakan SDM sedari dini (prenatal) dengan 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), penurunan Prevalensi stunting, penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi dan Balita. Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting merupakan Major Project dalam RPJMN 2020-2024.

Indonesia masih memiliki permasalahan yang besar pada kesehatan Ibu dan Wanita Usia Subur (WUS). Proporsi Kurang Energi Kronis pada WUS dan diiringi juga dengan peningkatan proporsi anemia pada ibu hamil.

Upaya perbaikan gizi dengan fokus pada pencegahan stunting. Stunting disebabkan oleh faktor dengan multi dimensi terutama pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), praktek pengasuhan yang kurang maksimal, minimnya pengetahuan tentang kesehatan dan gizi sebelum dan pada masa kehamilan.

Arah Kebijakan dan Strategi Percepatan perbaikan gizi masyarakat dalam RPJMN 2020-2024: a) penguatan komitmen, kampanye,

pemantauan dan evaluasi upaya perbaikan gizi masyarakat; b) pengembangan sistem jaminan gizi dan tumbuh kembang anak dengan pemberian jaminan asupan gizi sejak dalam kandungan, perbaikan pola asuh keluarga, dan perbaikan fasilitas air bersih dan sanitasi lingkungan; c) percepatan penurunan stunting dengan peningkatan efektivitas intervensi spesifik, perluasan dan penajaman intervensi sensitif secara terintegrasi; d) peningkatan intervensi yang bersifat life saving dengan didukung bukti (evidence based policy) termasuk fortifikasi pangan; e) penguatan advokasi dan komunikasi perubahan perilaku terutama mendorong pemenuhan gizi seimbang berbasis konsumsi pangan (food based approach); f) penguatan sistem surveilans gizi; g) peningkatan komitmen dan pendampingan bagi daerah dalam intervensi perbaikan gizi dengan strategi sesuai kondisi setempat; dan h) respon cepat perbaikan gizi dalam kondisi darurat.

2. Asdep Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P), melakukan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian (KSP) kebijakan dan penyusunan RAK (Rumusan Alternatif Kebijakan) terkait Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.

(1) Penyakit Tidak Menular (PTM)

- Dalam periode tiga dekade terakhir, telah terjadi perubahan beban penyakit dari penyakit menular menjadi penyakit tidak menular.
- Faktor risiko utama PTM adalah faktor metabolik (tekanan darah tinggi, gula darah tinggi, obesitas, dislipidemia, gangguan fungsi ginjal, malnutrisi pada maternal dan anak), faktor perilaku (perilaku diet, merokok, risiko kesehatan kerja, kurang aktivitas fisik, konsumsi alkohol), dan faktor lingkungan (polusi udara, kekerasan, kemiskinan). Pola makan tidak sehat berkontribusi pada terjadinya PTM.

(2) Penyakit Menular

- mengendalikan faktor risiko utama untuk menurunkan beban penyakit menular harus dipantau melalui pengawasan atau surveilans yang efektif secara rutin dan terkoordinasi.

- Tiga penyakit menular yang perlu menjadi perhatian khusus adalah tuberkulosis, HIV/AIDS dan malaria, selain penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I).
- Perhatian khusus juga ditujukan untuk penyakit-penyakit infeksi baru yang menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat, serta penyakit-penyakit tropis terabaikan (neglected tropical diseases)

Arah kebijakan P2P dalam RPJMN 2020-2024:

- (a). pencegahan dan pengendalian faktor risiko penyakit termasuk perluasan cakupan deteksi dini, penguatan surveilans real time, pengendalian vektor dan perluasan layanan berhenti merokok;
- (b). penguatan health security terutama peningkatan kapasitas untuk pencegahan, deteksi, dan respon cepat terhadap ancaman penyakit termasuk penguatan alert system kejadian luar biasa dan karantina kesehatan;
- (c). peningkatan cakupan penemuan kasus dan pengobatan serta penguatan tata laksana penanganan penyakit dan cedera;
- (d). pengendalian resistensi antimikroba;
- (e). pemberdayaan masyarakat dalam pengendalian penyakit dan penguatan sanitasi total berbasis masyarakat.

3. Asisten Deputi Peningkatan Pelayanan Kesehatan, melakukan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian (KSP) kebijakan dan penyusunan RAK (Rumusan Alternatif Kebijakan) terkait Pelayanan Kesehatan.

- Untuk peningkatan mutu pelayanan kesehatan, masih diperlukan upaya keras untuk meningkatkan cakupan dan tingkatan akreditasi FKTP (puskesmas dan klinik), sehingga target FKTP terakreditasi bisa mencapai 100 % di tahun 2024.
- RS Rujukan perlu terus dikembangkan dan ditingkatkan kualitas pelayanannya.
- Pemenuhan dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan.
- Pembiayaan Kesehatan.

- Sediaan farmasi dan alat kesehatan, tantangan yang dihadapi adalah disparitas ketersediaan obat dan alkes antar daerah, terutama di DTPK, serta ketersediaan antar tingkat pelayanan kesehatan. Disamping itu, kemandirian produk farmasi dan alkes dalam negeri belum tercapai, karena lebih dari 90% bahan baku obat adalah produk impor.

4. Asisten Deputi Peningkatan Pembangunan Kependudukan dan KB, melakukan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian (KSP) kebijakan dan penyusunan RAK (Rumusan Alternatif Kebijakan) terkait Kependudukan dan Keluarga Berencana.

Penduduk tumbuh seimbang merupakan salah satu prasyarat untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia. Penduduk tumbuh seimbang, daya tampung dan daya dukung lingkungan dapat tetap terjaga. Apalagi Indonesia akan memaksimalkan bonus demografi yang jika tidak dikelola dengan baik, dapat menyebabkan tingginya tingkat pengangguran, konflik sosial, serta tekanan pada pangan dan lingkungan.

Penduduk tumbuh seimbang ditandai dengan Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR) di angka 2,1 dan angka reproduksi netto (NRR) =1.

Sasaran dan indikator bidang PMK dalam RPJMN 2020-2024 terkait Pengendalian Penduduk dan Penguatan Tata Kelola Kependudukan adalah: 1). Angka Kelahiran Total/Total Fertility Rate, turun di angka 2,1 pada tahun 2024, base line di angka 2,28 (Supas, 2015); 2) Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi /Unmet Need KB turun menjadi 7,4% pada tahun 2024, base line di angka 10,6 (SDKI 2017); 3) Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19, turun menjadi 18 pada tahun 2024, base line di angka 36 (SDKI 2017).

5. Sekretaris Deputi, melakukan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi dan substansi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi PKKPK, Kemenko PMK.

3.1.5. Dukungan Kementerian/Lembaga Mitra

Disadari bahwa isu strategis di bidang PMK sangat kompleks dan harus melibatkan banyak K/L sehingga untuk menindaklanjuti setiap isu strategis yang ada dibutuhkan proses penyelarasan dan harmonisasi kebijakan yang dapat diperankan oleh Deputy Bidang Koordinasi PKKPK Kemenko PMK sesuai dengan tugas dan fungsi yang diamanatkan dalam Perpres Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara.

Peran, tugas, dan fungsi Kemenko PMK diharapkan dapat meminimalkan dan mereduksi masalah dan tantangan utama pembangunan, khususnya yang terkait PMK, berkontribusi pada pencapaian sasaran nasional, dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan PMK di bidang Kesehatan dan Kependudukan. Deputy Bidang Koordinasi PKKPK Kemenko PMK adalah salah satu bagian yang terlibat dalam suatu sistem pembangunan tersebut, dan akan memberikan kontribusi positif dan signifikan apabila peran, tugas, dan fungsi Deputy Bidang Koordinasi PKKPK Kemenko PMK dapat dijalankan secara efektif.

Secara lebih khusus peran, tugas, dan fungsi Deputy Bidang Koordinasi PKKPK Kemenko PMK adalah memberi dukungan langsung kepada K/L mitra terkait, khususnya K/L di bawah koordinasi Deputy Bidang Koordinasi PKKPK Kemenko PMK.

Strategi, program, dan kegiatan Deputy Bidang Koordinasi PKKPK Kemenko PMK dimaksudkan agar strategi, program, dan kegiatan K/L mitra dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Dalam hal ini, peran, tugas, dan fungsi Deputy Bidang Koordinasi PKKPK Kemenko PMK merupakan dukungan bagi terlaksananya strategi K/L mitra. Dari sisi lain, kinerja K/L memberi dukungan bagi strategi Deputy Bidang Koordinasi PKKPK Kemenko PMK. Semua keberhasilan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan K/L teknis akan memberi sumbangan positif bagi capaian kinerja Kemenko PMK secara keseluruhan.

Adapun kaitan logis antar sasaran dan fokus strategi, serta kaitan keduanya dengan strategi K/L mitra ditunjukkan dalam sebuah matriks seperti pada Tabel 3.6 Terlihat adanya kesinambungan antara Sasaran

Strategis, Fokus Strategi, serta Peran Deputi Bidang Koordinasi PKKPK Kemenko PMK dan K/L mitra. Matriks tersebut dapat dilihat baik secara horizontal maupun vertikal. Secara horizontal diperlihatkan Sasaran

Strategis pada masing-masing fokus strategi. Secara horizontal, diperlihatkan peran koordinasi Deputi Bidang Koordinasi PKKPK Kemenko PMK pada tiap fokus strategi. Secara horizontal pula diperlihatkan peran, tugas, dan fungsi Deputi Bidang Koordinasi PKKPK Kemenko PMK yang mendukung kinerja K/L terkait.

Tabel 3.6: Dukungan K/L Mitra terhadap Strategi KSP Kemenko PMK

SASARAN STRATEGIS	STRATEGI KSP					KOORDINASI DENGAN K/L MITRA
	SELARAS BASIS DATA	MANTAP PELAYANAN KEBUTUHAN DASAR	MANTAP PEMBERDAYAAN	MANTAP PEMBANGUNAN KARAKTER	PEMBANGUNAN DESA SEMESTA	
SS-1 Meningkatnya Implementasi Kebijakan Peningkatan Kualitas Kesehatan Dan Pembangunan Kependudukan (PKKPK)	Terimplementasinya basis data yang valid, terpercaya yang digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan K/L	Terimplementasinya Kebijakan di bidang Pelayanan Kebutuhan Dasar	Terimplementasinya Kebijakan di bidang Pembedayaan Masyarakat	Terimplementasinya Kebijakan di bidang Pembangunan Karakter	Terimplementasinya Kebijakan di bidang Pembangunan Desa Semesta	Kemenko PMK dan K/L Mitra Seluruh K/L Mitra, BPS, Bappenas, BKKBN, BNPB, DJSN
SS-2 Meningkatnya Kualitas Koordinasi Dan Sinkronisasi Perumusan Dan Penetapan Kebijakan PKKPK	Koordinasi Perumusan dan penetapan kebijakan dalam hal basis data nasional	Koordinasi Perumusan dan Penetapan Kebijakan di bidang Pelayanan Kebutuhan Dasar	Koordinasi Perumusan dan Penetapan Kebijakan di bidang Pembedayaan Masyarakat	Koordinasi Perumusan dan Penetapan Kebijakan di bidang Pembangunan Karakter	Koordinasi Perumusan dan Penetapan Kebijakan di bidang Pembangunan Desa Semesta	Kemenko PMK dan K/L Mitra Seluruh K/L Mitra, BPS, Bappenas, BKKBN, BNPB, DJSN
SS-3 Meningkatnya Kualitas Koordinasi Dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan PKKPK	Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan pengumpulan dan pengelolaan data nasional	Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan di bidang Pelayanan Kebutuhan Dasar	Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan di bidang Pemberdayaan Masyarakat	Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan di bidang Pembangunan Karakter	Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan di bidang Pembangunan Desa Semesta	Kemenko PMK dan K/L Mitra Seluruh K/L Mitra, BPS, Bappenas, BKKBN, BNPB, DJSN
SS-4 Meningkatnya Kualitas Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan PKKPK	Koordinasi Pengendalian, pemeliharaan dan evaluasi basis data	Koordinasi Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan di bidang Pelayanan Kebutuhan Dasar	Koordinasi Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan di bidang Pemberdayaan Masyarakat	Koordinasi Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan di bidang Pembangunan Karakter	Koordinasi Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan di bidang Pembangunan Desa Semesta	Kemenko PMK dan K/L Mitra Seluruh K/L Mitra, BPS, Bappenas, BKKBN, BNPB, DJSN
DUKUNGAN K/L MITRA	Seluruh K/L Mitra, BPS, Bappenas, BKKBN, BNPB, DJSN	Seluruh K/L Mitra, BPS, Bappenas, BKKBN, BNPB, DJSN	Seluruh K/L Mitra, BPS, Bappenas, BKKBN, BNPB, DJSN	Seluruh K/L Mitra, BPS, Bappenas, BKKBN, BNPB, DJSN	Seluruh K/L Mitra, BPS, Bappenas, BKKBN, BNPB, DJSN	

3.2. Kerangka Regulasi

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategis Deputy Bidang Koordinasi PKKPK, diusulkan Rancangan Undang-Undang yang menjadi bidang tugas Deputy Bidang Koordinasi PKKPK maupun yang terkait dengan bidang tugas Deputy Bidang Koordinasi PKKPK untuk ditetapkan dalam Program Legislasi Nasional Jangka Menengah Tahun 2020-2024.

Sebagai Kementerian Koordinator yang mempunyai fungsi mengoordinasikan dan menyinkronisasikan perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan K/L yang terkait dengan isu PMK di bidang kesehatan dan kependudukan, maka regulasi yang dibutuhkan tidak hanya untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Deputy Bidang Koordinasi PKKPK Kemenko PMK dalam pencapaian sasaran strategis, melainkan juga regulasi yang dibutuhkan K/L dalam rangka percepatan penyelesaian permasalahan dan isu-isu strategis PMK di bidang kesehatan dan kependudukan. Oleh karena itu, pada bagian ini akan disusun kerangka regulasi nasional dalam rangka penyelesaian isu-isu strategis bidang PMK.

Beberapa regulasi yang dapat mempermudah pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian sesuai dengan tugas dan fungsi Kemenko PMK yang diusulkan berupa perbaikan/amandemen dari regulasi yang sudah ada, atau usulan regulasi baru yang dibutuhkan dalam pencapaian sasaran strategis Kemenko PMK. Usulan kerangka regulasi secara detail dapat dilihat pada Lampiran 1.

3.3 Kerangka Kelembagaan

Dalam rangka mencapai visi, misi, dan strategi Deputy Bidang Koordinasi PKKPK sebagaimana telah dijabarkan pada bab sebelumnya, Deputy Bidang Koordinasi PKKPK harus didukung oleh perangkat organisasi, proses bisnis, tata laksana, dan sumber daya aparatur yang mampu melaksanakan tugas yang dibebankan kepada Deputy Bidang Koordinasi PKKPK secara efektif dan efisien. Untuk itu kegiatan pengembangan dan penataan kelembagaan yang meliputi organisasi dan ketatalaksanaan, serta pengelolaan sumber daya aparatur mutlak dilaksanakan secara efektif, intensif, dan berkesinambungan.

Dalam melakukan penataan kelembagaan dan pengelolaan sumber daya aparatur, Deputy Bidang Koordinasi PKKPK berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Kedudukan, tugas dan fungsi Deputy Bidang Koordinasi PKKPK Kemenko PMK sebagai berikut:

3.3.1 Struktur Organisasi

Pada prinsipnya, struktur organisasi berperan untuk mendorong efektivitas pelaksanaan pembangunan dengan dukungan kelembagaan yang tepat ukuran, tepat fungsi, dan tepat proses. Dalam konteks Mekanisme Penghantaran (delivery mechanism), kelembagaan difokuskan pada penataan organisasi pemerintah beserta aturan main di dalamnya, baik yang bersifat inter maupun antar organisasi, yang berfungsi untuk melaksanakan program-program pembangunan.

Dalam penyusunan kerangka kelembagaan Deputy Bidang Koordinasi PKKPK Kemenko PMK, dasar penyusunan mengacu kepada isu strategis bidang PMK dalam dokumen RPJMN 2020-2024. Hal ini bertujuan agar arah koordinasi tidak lagi bersifat sektoral namun multisektor, sehingga mempercepat pencapaian sasaran dan target nasional di bidang PMK. Sejalan dengan hal tersebut kerangka kelembagaan Deputy Bidang Koordinasi PKKPK Kemenko PMK telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden nomor 35 tahun 2020 sebagaimana dapat dilihat pada Lampiran 2.

Perpres No. 35 Tahun 2020 memberikan kewenangan kepada Kemenko PMK untuk menanggapi dinamika pembangunan yang berkembang. Menurut Perpres ini, di lingkungan Kemenko PMK dapat ditetapkan jabatan fungsional tertentu sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dilihat dari jumlah isu strategis Kemenko PMK yang cukup banyak, diperlukan struktur organisasi yang tepat baik secara komposisi, substansi, serta dukungan kesekretariatan dalam mendukung struktur berdasarkan Perpres 35/2020.

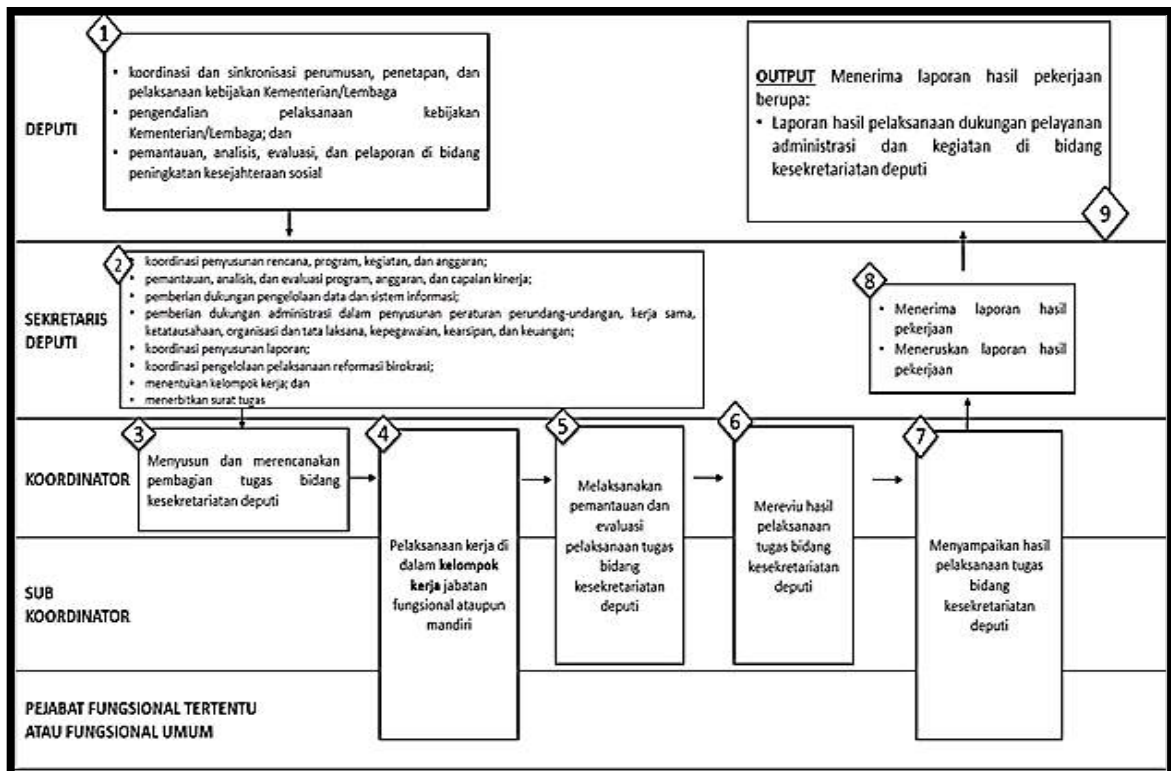
3.3.2 Proses Bisnis

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan kepuasan pemangku kepentingan dalam pelaksanaan tugas sebagai lembaga

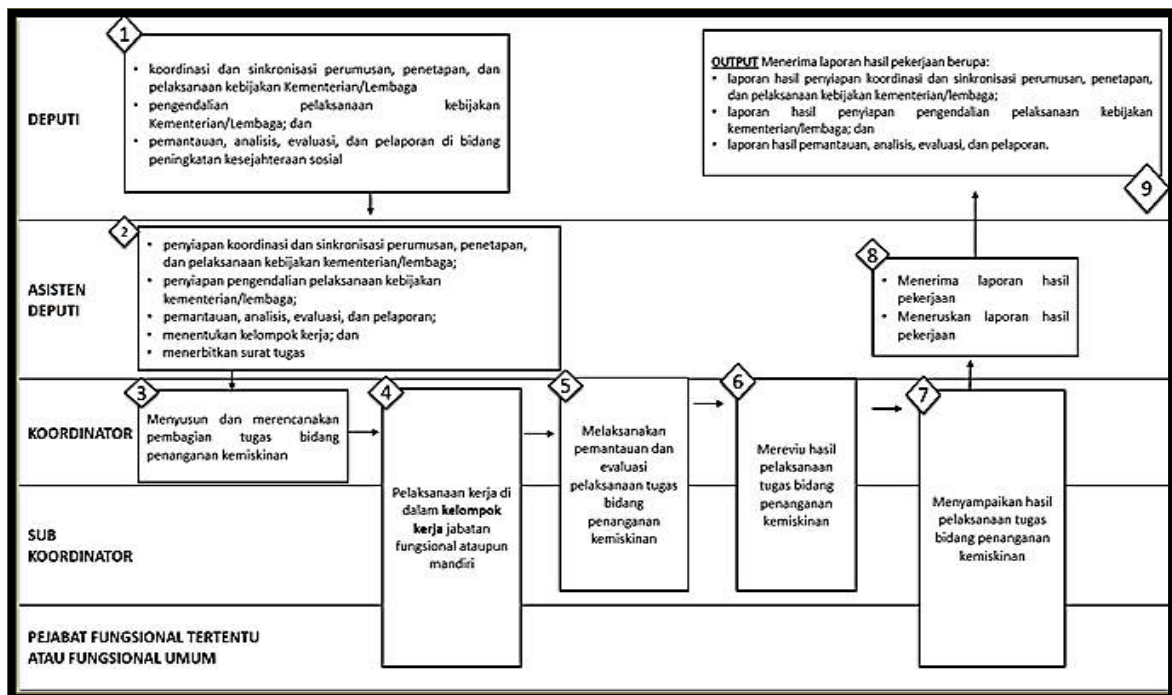
koordinator pelaksanaan pembangunan manusia dan kebudayaan, sudah saatnya pada periode 2020-2024 Kemenko PMK menerapkan sistem manajemen mutu atau Quality Management System berdasarkan persyaratan ISO 9001:2015 melalui jaminan kesesuaian pada persyaratan pelanggan dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta proses peningkatan sistem secara berkelanjutan.

Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, maka kementerian koordinator diharuskan menyusun proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit kerja di lingkungan Kemenko PMK dan proses bisnis penanganan isu bidang PMK antar K/L yang masing-masing ditetapkan dengan Peraturan Menko PMK.

Gambar 3.7. Hubungan Pola Kerja pada Sekretariat Deputy Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas kesehatan dan Pembangunan Kependudukan



Gambar 3.8. Hubungan Pola Kerja pada Asisten Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas kesehatan dan Pembangunan Kependudukan



3.3.3 Sumber Daya Manusia

Sejalan dengan RPJMN 2020-2024 dan penyusunan Rencana Induk Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 2020-2024, maka pada Renstra Deputy Bidang Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan 2020-2024 diperlukan upaya peningkatan SDM yang berkualitas dan berdaya saing. Salah satu aspek strategis yang perlu mendapatkan perhatian dan prioritas adalah pengembangan kualitas SDM bagi Pejabat Struktural dan Pejabat Fungsional Tertentu.

Pada periode 2015- 2019 kebutuhan akan pentingnya pengembangan kualitas SDM ini masih kurang, sehingga pada periode 2020-2024 menjadi momen untuk meningkatkan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil. Terlebih Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil menegaskan perlunya peningkatan kompetensi pegawai negeri sipil dengan memberikan pendidikan dan pelatihan minimal selama 20 jam/tahun. Pengelolaan

SDM, termasuk di dalamnya mengenai kebutuhan SDM, baik secara kualitas maupun kuantitas perlu dilakukan dengan program strategis yang bersifat terobosan.

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

Untuk mewujudkan visi dan misi Deputy Bidang Koordinasi PKKPK Kemenko PMK serta mendukung tercapainya kebijakan pada level nasional, Deputy Bidang Koordinasi PKKPK menetapkan kegiatan dan telah dilengkapi dengan tujuan. Tujuan tersebut merupakan kondisi yang ingin dicapai secara nyata oleh Deputy Bidang Koordinasi PKKPK dan mencerminkan pengaruh atas ditimbulkannya hasil (outcome) dari satu atau beberapa kegiatan.

Program yang dijalankan oleh Deputy Bidang Koordinasi PKKPK dalam rangka mendukung visi dan misi Deputy Bidang Koordinasi PKKPK adalah Program Koordinasi Kebijakan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Bidang Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan. Program ini bertujuan agar terlaksananya fungsi penganggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah secara transparan dan akuntabel.

Tingkat keberhasilan pencapaiannya program diukur dengan menggunakan Indikator Kinerja Program (IKP) sebagai berikut:

4.1. Target Kinerja

Keberhasilan pelaksanaan Renstra Deputy Bidang Koordinasi PKKPK Kemenko PMK 2020–2024 diukur dengan berbagai indikator kinerja beserta target kinerjanya. Pada bagian ini akan diuraikan target yang ditetapkan untuk indikator kinerja sasaran strategis, indikator kinerja program, dan indikator kinerja kegiatan.

4.1.1. Indikator Kinerja Sasaran Strategis

Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) Deputy Bidang Koordinasi PKKPK Kemenko PMK untuk Pembangunan Jangka Menengah periode 2020–2024 merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian sasaran strategis Deputy Bidang Koordinasi PKKPK Kemenko PMK dalam kurun waktu tersebut. Adapun IKSS Deputy Bidang

Koordinasi PKKPK Kemenko PMK Tahun 2020–2024 beserta target kinerjanya diuraikan pada Lampiran 3.

4.1.2. Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan, maka dalam kurun waktu 2020–2024, perlu ditetapkan dengan Indikator Kinerja Program (IKP) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). IKP adalah alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian hasil (outcome) dari suatu program pada unit kerja Eselon I. IKP ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran program. Sedangkan IKK adalah alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian keluaran (output) dari suatu kegiatan pada satuan kerja Eselon II. IKK ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja yang berkaitan dengan sasaran kegiatan. IKP dan IKK dari masing-masing program dan kegiatan Kemenko PMK dalam kurun waktu 2020–2024 dapat dilihat pada Lampiran 4.

4.1.3. Kaitan IKP dan IKK Deputy Bidang Koordinasi PKKPK Kemenko PMK dan K/L

Terkait dengan penilaian kinerja deputy Bidang PKKPK dengan berbagai indikator pada Lampiran 3, perlu dikemukakan bahwa penggunaan berbagai IKP dan IKK harus didasari oleh persepsi pemahaman yang sama. Sebagai Unit Kerja Eselon I di Kementerian Koordinator, Deputy Bidang PKKPK mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan KSP dalam rangka pencapaian kinerja K/L terkait.

Realisasi pencapaian IKP dan IKK Kemenko PMK terkait langsung dengan K/L yang merupakan milik dan pelaksana atas program atau kegiatan tertentu. Dalam pencapaian Indikator-indikator tersebut, peran dan kontribusi Kemenko PMK harus ditempatkan secara proporsional dalam pemahaman tugas dan fungsi KSP.

Meskipun Indikator Kinerja tertentu merupakan Indikator Kinerja K/L terkait, namun, dilihat dari aspek koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian yang dilakukan Kemenko PMK, indikator-indikator tersebut juga secara tidak langsung mencerminkan Indikator Kinerja Kemenko PMK.

4.2. Kerangka Pendanaan

Untuk mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan Deputy Bidang Koordinasi PKKPK, Kemenko PMK, diperlukan dukungan berbagai macam sumber daya. yang dapat berasal dari aparaturnya Deputy Bidang Koordinasi PKKPK yang kompeten, sarana dan prasarana yang memadai, dukungan regulasi, serta sumber pendanaan yang cukup.

Adapun kerangka pendanaan yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan keseluruhan program dan kegiatan Deputy Bidang Koordinasi PKKPK, Kemenko PMK tahun 2020 - 2024 sebagai berikut:

Tabel 4.1: Indikasi Kebutuhan Pendanaan Deputy Bidang Koordinasi PKKPK Tahun 2020-2024 (Setelah Review Renstra Menko PMK Tahun 2022, setelah RSPP)

Program/ Kegiatan/KRO/RO	Sasaran Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Indikator	Target					Alokasi Dalam Juta Rupiah				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan	Meningkatnya koordinasi dalam mengembangkan dan menyerasikan kebijakan Bidang Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan dan Pemuda						-	3.126	4.500	4.602	4.707
	• Jumlah Perumusan Kebijakan (RK) di bidang Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan	4	4	4	4	4					
	• Jumlah Perumusan Kebijakan (RK) yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan bidang Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan	3	2	2	2	2					
	• Indeks kepuasan pemangku kepentingan terhadap proses koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan	4,80 (Skala 6)	5,27 (Skala 6)	5,28 (Skala 6)	5,32 (Skala 6)	5,37 (Skala 6)					
KEGIATAN 17: Penyelenggaraan Pelayanan Sekretariat Deputy Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan											
	Tersusunnya dokumen program dan administratif kegiatan bidang Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan										
	• Jumlah dokumen program dan administratif kegiatan bidang Peningkatan Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan	2	2	2	2	2					
Rincian Output: 001-Rekomendasi Alternatif Kebijakan Bidang Ketahanan Gizi dan Promosi Kesehatan											
	• Jumlah Rekomendasi Alternatif Kebijakan (RAK) di bidang Ketahanan Gizi dan Promosi kesehatan	3	3	2	2	2					
Rincian Output: 002-Rekomendasi Alternatif Kebijakan Bidang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit											
	- Jumlah Rekomendasi Alternatif Kebijakan (RAK) di bidang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit	3	3	2	2	2					

Program/ Kegiatan/KRO/RO	Sasaran Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Indikator	Target					Alokasi Dalam Juta Rupiah				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Rincian Output: 003-Rekomendasi Alternatif Kebijakan Bidang Peningkatan Pelayanan Kesehatan											
	- Jumlah Rekomendasi Alternatif Kebijakan (RAK) di bidang Pelayanan Kesehatan	3	3	2	2	2					
Rincian Output: 003-Rekomendasi Alternatif Kebijakan Bidang Peningkatan Kualitas Kependudukan dan Keluarga Berencana											
	- Jumlah Rekomendasi Alternatif Kebijakan (RAK) di bidang Peningkatan Kualitas Kependudukan dan Keluarga Berencana	3	3	2	2	2					

Berdasarkan prakiraan kebutuhan pendanaan tersebut, Deputi Bidang Koordinasi PKKPK menyusun Renstra Tahun 2020-2024 sebagai pedoman untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan serta tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Tabel 4.1 menunjukkan kerangka pendanaan setelah Review Renstra Kemenko PMK dimana level kegiatan sudah mencerminkan Eselon I. Uraian program dan kegiatan sebelum review renstra Menko PMK dimana level kegiatan masih menunjukkan level eselon 2 dapat dilihat pada Lampiran 4 sebagai perbandingan.

BAB V

P E N U T U P

5.1. Kesimpulan

Rencana Strategis Deputy Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan Tahun 2020-2024, disusun dengan mengacu kepada Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Tahun 2020-2024. Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Tahun 2020-2024 tersebut merupakan penjabaran dari Visi dan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Renstra Deputy Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan Tahun 2020-2024 mencerminkan upaya peningkatan dan optimalisasi peran Deputy Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan sesuai Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dalam menjalankan tugas dan fungsi koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang peningkatan kualitas kesehatan dan pembangunan kependudukan.

Sebagai cerminan dari upaya tersebut, Deputy Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan telah mencanangkan visi untuk periode Tahun 2020-2024, yaitu: “Menjadi Unit kerja koordinator pelaksanaan Peningkatan kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan (PKKPK) yang efektif dan berkelanjutan untuk mewujudkan Indonesia MAJU yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”. Untuk dapat mewujudkan visi ini, Deputy Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan

Pembangunan Kependudukan telah merumuskan dua pernyataan misi, yaitu: (1). Meningkatkan pembangunan manusia dan kebudayaan yang berkualitas dan berkelanjutan melalui peningkatan kualitas kesehatan dan pembangunan kependudukan; (2). Meningkatkan kapasitas kelembagaan. Visi dan Misi Deputy Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan sebagaimana diuraikan di atas, mengacu dan selaras dengan Visi dan Misi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang tertuang dalam Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Tahun 2020–2024.

Dengan demikian, Deputy Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan yang memiliki bisnis utama koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang peningkatan kualitas kesehatan dan pembangunan kependudukan, akan melaksanakan mandat sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Tahun 2020-2024. Penyelenggaraan pelaksanaan bisnis utama tersebut dapat diindikasikan pencapaiannya melalui kebijakan Trimantap, yaitu mantap pelayanan, mantap pemberdayaan, dan mantap pembangunan karakter.

5.2. Arah Pimpinan dan Pelaksanaan Renstra

Mandat penyelenggaraan koordinasi kelembagaan yang diamanatkan kepada Deputy Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan demikian luas dan melibatkan banyak K/L. Hal ini dimaklumi mengingat luasnya dinamika Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan, luasnya irisan dan keterkaitan antar unsur-unsur atau komponen-komponen pembentuk Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan, keterpaduan yang tak terpisahkan antara kualitas fisik dan nonfisik dalam Bidang Peningkatan Kualitas Kesehatan

dan Pembangunan Kependudukan, dan keterkaitan yang tak terpisahkan antara dimensi masyarakat dengan individu, keterkaitan antarwaktu, serta keterkaitan antarwilayah. Oleh karena itu, Deputy Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan perlu membuat fokus penyelenggaraan koordinasi yang memiliki karakteristik dan dapat berkontribusi serta berdampak luas pada pencapaian peningkatan kualitas kesehatan dan pembangunan kependudukan nasional secara keseluruhan.

Mempertimbangkan kondisi lingkungan internal dan eksternal, masalah dan potensi, isu strategis sebagaimana telah diuraikan dalam pembahasan kondisi umum, tantangan pembangunan nasional, agenda pembangunan (Nawacita), maupun subagenda dan sasaran pembangunan yang terkait dengan peningkatan kualitas kesehatan dan pembangunan kependudukan nasional, serta mandat koordinasi yang diamanatkan kepada Deputy Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan dalam Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Tahun 2020-2024, maka Deputy Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan mengelompokkan secara garis besar lima fokus koordinasi program dan kegiatan dalam agenda kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan. Lima fokus koordinasi tersebut adalah: (1) Selaras Basis Data, (2) Jaminan Kebutuhan dan Pelayanan Dasar, (3) Pemberdayaan Masyarakat, (4) Pembangunan Manusia Berkarakter, dan (5) Pembangunan Desa Semesta.

Fokus tersebut dijabarkan ke dalam tujuan strategis Deputy Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan untuk periode Tahun 2020-2024, yaitu:

1. Terwujudnya Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan yang berkesinambungan; dan
2. Tercapainya birokrasi yang handal, terpercaya, dan akuntabel pada Deputy Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan.

Secara operasional, pelaksanaan seluruh program dan kegiatan Deputy Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan dalam rangka mewujudkan tujuan strategis sebagaimana yang telah ditetapkan di atas, pada periode lima tahun mendatang akan dilaksanakan melalui 5 (lima) kegiatan, yaitu: (1) Penyelenggaraan Pelayanan Kesekretariatan Deputy Bidang Koordinasi PKKPK, (2) Koordinasi Ketahanan Gizi Dan Promosi Kesehatan, (3) Koordinasi kebijakan Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit, (4) Koordinasi Kebijakan Pelayanan Kesehatan, dan (5) Koordinasi kebijakan Peningkatan Kualitas Kependudukan dan Keluarga Berencana.

5.3. Mekanisme Evaluasi atas Renstra

Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan Renstra Deputy Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan Tahun 2020–2024 membutuhkan komitmen yang tinggi dari seluruh jajaran Deputy Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan. Keinginan kuat untuk melakukan perubahan yang bersifat strategis di level Deputy Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan merupakan bentuk nyata dari komitmen yang tinggi tersebut. Untuk itu, dalam Renstra Deputy Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan 2020–2024 setiap tujuan strategis dikaitkan dengan sejumlah sasaran strategis, indikator kinerja sasaran strategis, arah kebijakan, serta program dan kegiatan. Program dan kegiatan telah disusun dengan mempertimbangkan kondisi, potensi, dan permasalahan terkini. Untuk memastikan agar seluruh program dan kegiatan masing-masing menghasilkan outcome dan output yang diharapkan, proses pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja organisasi yang dikaitkan dengan pelaksanaan Renstra ini harus berjalan secara berkelanjutan.

Pemantauan dan evaluasi kinerja hasil pelaksanaan Renstra Deputy Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan

Pembangunan Kependudukan Tahun 2020–2024 harus berlangsung dengan mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas kinerja.

Oleh karena itu, secara lebih operasional, Renstra Deputy Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan Tahun 2020-2024 akan dijabarkan lebih lanjut setiap tahunnya ke dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) Deputy Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan. Renstra dan RKT Deputy Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan inilah yang menjadi pedoman utama seluruh unit kerja eselon II di lingkungan Deputy Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan dalam menjabarkan isu-isu strategis yang perlu dikoordinasikan, disinkronisasikan, dan dikendalikan dalam lima fokus koordinasi yang disusun dalam Renstra dan RKT, hingga dijabarkan dalam Perjanjian Kinerja secara berjenjang dari Deputy, pejabat Eselon II, III, IV, dan pelaksana/pejabat fungsional di lingkungan Deputy Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan. Melalui mekanisme tersebut, seluruh pegawai Deputy Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan harus menyadari bahwa mereka memiliki komitmen yang dibutuhkan untuk melakukan perubahan, serta memiliki budaya untuk menghasilkan kinerja tinggi. Dengan modal ini, Deputy Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan optimis bahwa seluruh target kinerja sebagaimana ditetapkan dalam Renstra Deputy Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan Tahun 2020-2024 ini dapat diraih.

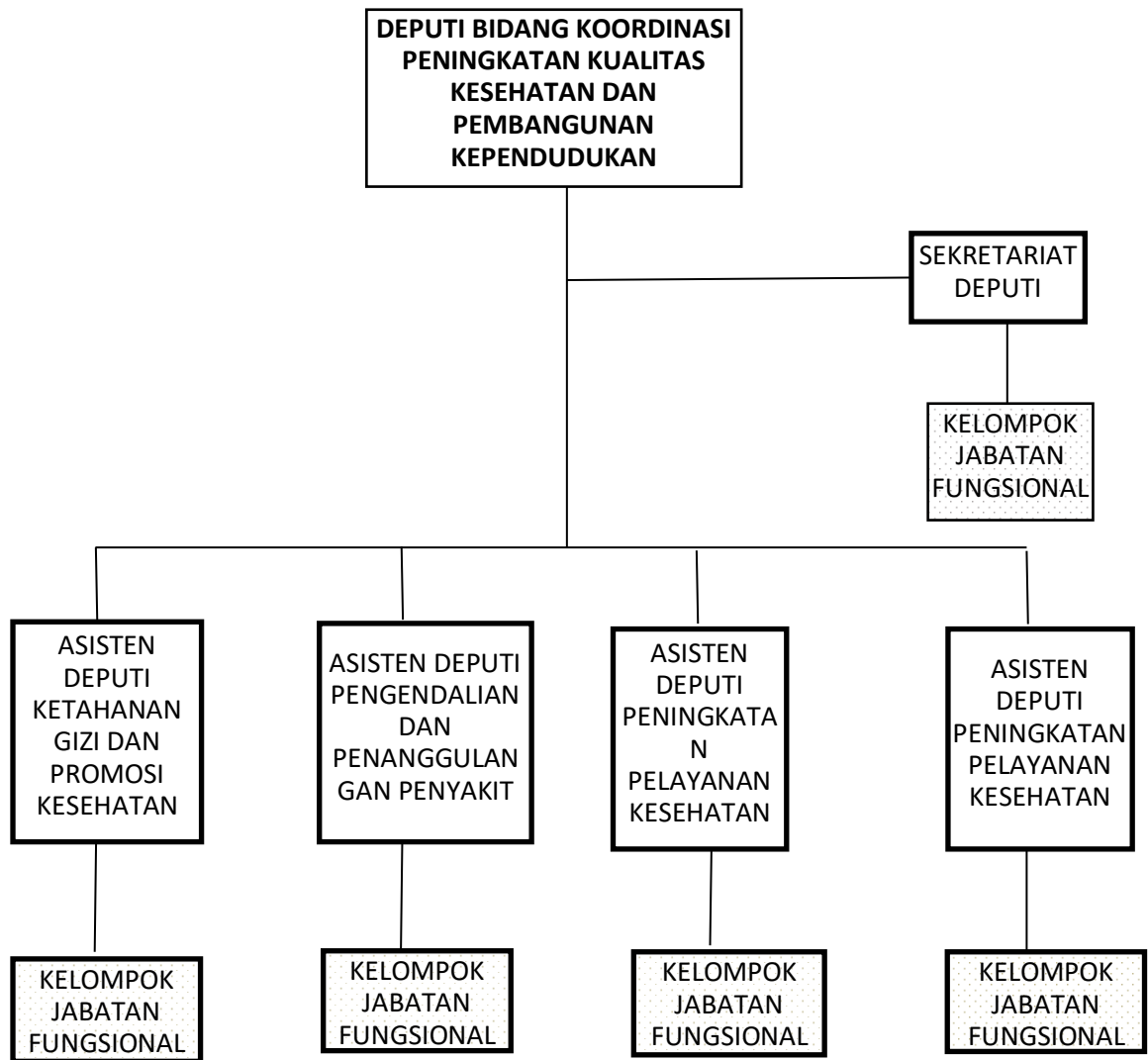


Lampiran 1 : Prioritas Revisi Regulasi (dalam RPJMN 2020-2024) yang menjadi domain Deputy Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kependudukan dan Keluarga Berencana dan K/L Terkait.

AGENDA PEMBANGUNAN / PRIORITAS NASIONAL	KERANGKA REGULASI		
	UU	PP	Perpres
Agenda Pembangunan Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	1. Revisi UU Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular 2. Rancangan Undang-Undang tentang Pertembakauan; 3. Rancangan Undang-Undang tentang Kependudukan dan Keluarga Nasional; 4. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 5. Rancangan Undang-Undang tentang Kesehatan Masyarakat; 6. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional; 7. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran; 8. Rancangan Undang-Undang tentang Pengawasan Obat dan Makanan; 9. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran; 10. Rancangan Undang-Undang tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak;	1. RPP Standar Mutu Pelayanan Kesehatan 2. RPP tentang Upaya Kesehatan Sekolah 3. RPP tentang Peraturan Pelaksanaan UU Kekarantinaan Kesehatan 4. RPP tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan 5. RPP tentang Label dan Iklan Pangan 6. Revisi PP Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan 7. RPP tentang Upaya Kesehatan Jiwa 8. RPP tentang Keamanan Pangan	1. RPerpres tentang Kabupaten / Kota Sehat 2. RPerpres tentang Sertifikasi Halal Produk Obat, Produk Biologi dan Alat Kesehatan 3. Rperpres tentang Percepatan Penurunan Stunting; 4. Rperpres tentang Penanggulangan Tuberkulosis

AGENDA PEMBANGUNAN / PRIORITAS NASIONAL	KERANGKA REGULASI		
	UU	PP	Perpres
	11.RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular		

Lampiran 2 : Struktur Organisasi Deputy Bidang Koordinasi PKKPK, Kemenko PMK 2020-2024.



Lampiran 3 : Sasaran Strategis dan Indikator Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan, Kemenko PMK

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	TARGET 2020	TARGET 2024	CARA PENGUKURAN
SS-1 Meningkatnya Implementasi Kebijakan Peningkatan Kualitas Kesehatan Dan Pembangunan Kependudukan (PKKPK)	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	24,1	14	Proses pengukuran dilakukan Kementerian Kesehatan.
	Persentase imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12-23 bulan	64	90	
	Persentase rumah sakit terakreditasi	80	100	
	Angka kelahiran Total (TFR)	2,26	2,1	
SS-2 Meningkatnya Kualitas Koordinasi Dan Sinkronisasi Perumusan Dan Penetapan Kebijakan PKKPK	Persentase isu-isu strategis bidang PMK yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan	20%	100%	Jumlah isu-isu strategis bidang PMK yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan bidang PMK dalam jangka waktu lima tahun. Setiap tahun minimal 20% isu-isu strategis ditindaklanjuti menjadi kebijakan disesuaikan dengan unit pelaksana (deputi) Kemenko PMK
	Jumlah Rekomendasi Kebijakan (RK) di bidang Peningkatan kualitas kesehatan dan pembangunan kependudukan yang dihasilkan	4	4	Jumlah rekomendasi kebijakan bidang Peningkatan kualitas kesehatan dan pembangunan kependudukan yang dihasilkan setiap tahunnya disesuaikan dengan unit pelaksana (deputi) Kemenko PMK

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	TARGET 2020	TARGET 2024	CARA PENGUKURAN												
SS-3 Meningkatnya Kualitas Koordinasi Dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan PKKPK	Indeks kepuasan pemangku kepentingan Atas koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan	4,80 (SKALA 6)	5,37 (SKALA 6)	Survey yang dilakukan kepada kementerian dan lembaga lingkup Kemenko PMK, dan dilakukan bersama Pihak Ketiga setiap akhir tahun.												
SS-4 Meningkatnya Kualitas Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan PKKPK	Indeks Pengendalian program bidang PKKPK	Level 3	Level 5	Indeks yang menggambarkan prosentase capaian indikator-indikator bidang peningkatan kualitas kesehatan dan pembangunan kependudukan ((Jumlah indikator bidang PMK yang tercapai: Jumlah indicator bidang PMK). Dilihat dari indicator: - prevalensi stunting; - Persentase imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12-23 bulan; - Persentase rumah sakit terakreditasi; - Angka kelahiran Total (TFR). <table><tr><td>Capaian</td><td>Nilai Indeks</td></tr><tr><td>91 – 100%</td><td>5</td></tr><tr><td>81 – 90%</td><td>4</td></tr><tr><td>71 – 80%</td><td>3</td></tr><tr><td>61 – 70%</td><td>2</td></tr><tr><td><60%</td><td>1</td></tr></table>	Capaian	Nilai Indeks	91 – 100%	5	81 – 90%	4	71 – 80%	3	61 – 70%	2	<60%	1
Capaian	Nilai Indeks															
91 – 100%	5															
81 – 90%	4															
71 – 80%	3															
61 – 70%	2															
<60%	1															
SS-5 Meningkatnya efektivitas birokrasi Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan	Nilai Reformasi Birokrasi (Baseline Nilai SAKIP 2019: 78,26)	80,01	85,50	Hasil penilaian Reformasi Birokrasi Kemenko PMK oleh KempAN-RB terhadap 8 area perubahan yang dilaporkan dengan nilai SAKIP.												

Lampiran 4 : Matriks Kinerja dan Pendanaan (setelah RSPP)

Program/ Kegiatan /KRO/RO	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (Dalam Juta Rupiah)					Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
Rincian Output: 005-Layanan Perencanaan Sekretariat Deputy Bidang Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan													Sesdep
	Jumlah Layanan Perencanaan Sekretariat Deputy Bidang Peningkatan Kualitas Kesehatan			1	-	-	-						
Rincian Output: 015-Layanan Umum Sekretariat Deputy Bidang Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan													
	Jumlah Layanan Umum Sekretariat Deputy Bidang Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan			1	-	-	-						
Rincian Output: 005-Layanan Pemantauan dan Evaluasi Sekretariat Deputy Bidang Peningkatan Kualitas													

Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan													
	Jumlah Layanan Pemantauan dan Evaluasi Sekretariat Deputy Bidang Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan												
PROGRAM 036.CL: Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan													
	Meningkatnya koordinasi dalam mengembangkan dan menyerasikan kebijakan bidang Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan												
	- Jumlah Rekomendasi Kebijakan (RK) di bidang Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan yang dihasilkan			4	4	4	4						
	- Jumlah Rekomendasi Kebijakan (RK) yang			2	2	2	2						

	ditindaklanjuti menjadi kebijakan bidang Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan												
	- Indeks kepuasan pemangku kepentingan terhadap proses koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan			5,27 (Skala 6)	5,28 (Skala 6)	5,32 (Skala 6)	5,37 (Skala 6)						
KEGIATAN 6339: Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan								-	3.126	4.500	4.602	4.707	Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan
	Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan (RK) di bidang Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan												

	- Jumlah Rekomendasi Kebijakan (RK) di bidang Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan			4	4	4	4						
Klasifikasi Rincian Output: ABG Kebijakan Bidang Kesehatan													
	- Jumlah Kebijakan Bidang Kesehatan			4	4	4	4						
Rincian Output: 001- Rekomendasi Alternatif Kebijakan Bidang Ketahanan Gizi dan Promosi Kesehatan													Asdep Ketahanan Gizi dan Promosi Kesehatan Ketahanan Gizi dan Promosi Kesehatan
	- Jumlah Rekomendasi Alternatif Kebijakan Bidang Ketahanan Gizi dan Promosi Kesehatan			3	2	2	2						
Rincian Output: 002- Rekomendasi Alternatif Kebijakan Bidang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit													Asdep Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit
	- Jumlah Rekomendasi Alternatif Kebijakan Bidang			3	2	2	2						

	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit												
Rincian Output: 003- Rekomendasi Alternatif Kebijakan Bidang Peningkatan Pelayanan Kesehatan													Asdep Peningkatan Pelayanan Kesehatan
	- Jumlah Rekomendasi Alternatif Kebijakan Bidang Peningkatan Pelayanan Kesehatan			3	2	2	2						
Rincian Output: 004- Rekomendasi Alternatif Kebijakan Bidang Peningkatan Kualitas Kependudukan dan KB													Asdep Peningkatan Kualitas Kependudukan dan KB
	- Jumlah Rekomendasi Alternatif Kebijakan Bidang Peningkatan Kualitas Kependudukan dan KB			3	2	2	2						

Lampiran 5 :Matriks Kinerja dan Pendanaan (sebelum RSPP)

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (Dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
Penyelenggaraan Pelayanan Kesekretariatian Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan.								439	1.000	1.000	1.000	1.000	Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan
	Tersusunnya dokumen program dan administratif kegiatan bidang Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Keluarga.												
	- Jumlah dokumen program dan administratif kegiatan bidang Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Keluarga.		3	3	3	3	3						
Koordinasi Ketahanan Gizi Dan Promosi Kesehatan								1.561	1.300	1.300	1.300	1.300	Asdep Ketahanan Gizi Dan Promosi

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (Dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Tersusunnya Rumusan Alternatif Kebijakan (RAK) di bidang Ketahanan Gizi Dan Promosi Kesehatan												Kesehatan
	- Jumlah Rumusan Alternatif Kebijakan (RAK) di bidang Ketahanan Gizi Dan Promosi Kesehatan		3	3	3	3	3						
	- Jumlah Rumusan Alternatif Kebijakan (RAK) yang ditindaklanjuti menjadi Perumusan Kebijakan (RK) bidang di bidang Ketahanan Gizi Dan Promosi		1	1	1	1	1						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (Dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Kesehatan												



RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020 - 2024

